



Nuansa
Fajar
Cemerlang

PEMBERDAYAAN REMAJA MELALUI PEER EDUCATOR BERBASIS LITERASI DIGITAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING PADA REMAJA

Tavip Dwi Wahyuni • Atti Yudiernawati
Pudji Suryani



PEMBERDAYAAN REMAJA MELALUI *PEER EDUCATOR* BERBASIS LITERASI DIGITAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING PADA REMAJA

Penulis:

Tavip Dwi Wahyuni, S.Kep., Ns., M.Kes.

Dr. Atti Yudiernawati, S.Kp., M.Pd.

Pudji Suryani, SKp., MKM.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Pemberdayaan Remaja Melalui *Peer Educator* Berbasis Literasi Digital Dalam Upaya Pencegahan Stunting Pada Remaja

Penulis: Tavip Dwi Wahyuni, S.Kep, Ns, M.Kes.
Dr. Atti Yudiernawati, S.Kp, MPd.
Pudji Suryani, SKp, MKM.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Helmi Syaokani

ISBN: 978-634-7097-74-3

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Pemberdayaan remaja melalui peer educator berbasis literasi digital dalam upaya pencegahan stunting pada remaja / penulis, Tavip Dwi Wahyuni, S.Kep., Ns., M.Kes., Dr. Atti Yudiernawati, S.Kp., M.Pd., Pudji Suryani, S.Kp., M.K.M.
EDISI	Cetakan pertama
PUBLIKASI	Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025
DESKRIPSI FISIK	99 halaman ; 30 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-7097-74-3
SUBJEK	Remaja
KLASIFIKASI	305. 235 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1182859

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Berkat rahmat dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan pekerjaan mulia yakni menulis. Solawat juga salam semoga tetap tercurah kepada junjungan, Nabi Muhammad SAW. yang syafaatnya senantiasa dinanti-nantikan oleh umatnya di yaumul akhir.

Buku yang berjudul **"Pemberdayaan Remaja Melalui *Peer Educator* Berbasis Literasi Digital Dalam Upaya Pencegahan Stunting Pada Remaja"** memberikan edukasi kepada remaja tentang bentuk pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat, terutama dalam pencegahan stunting.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Malang, Ketua Jurusan Promosi Kesehatan dan seluruh pihak yang telah terlibat serta mendukung secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan buku ini. Tanpa andil dari pihak-pihak tersebut, mustahil buku ini dapat terselesaikan. Penulis juga mengakui jika masih banyak terdapat kekurangan dari buku ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan penulis.

Demikian, semoga buku sederhana ini dapat bermanfaat. Selamat membaca.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB 1 PENDAHULUAN 1

BAB 2 PEMBERDAYAAN REMAJA PENCEGAHAN STUNTING 7

A. Konsep Stunting	7
B. Pencegahan Stunting	11
C. Pemberdayaan Remaja	17
D. Konsep <i>Peer Educator</i>	28
E. Tugas <i>Peer Educator</i>	37
F. <i>Peer Educator</i> pada Remaja	39
G. Dampak Positif <i>Peer Educator</i>	42
H. Tantangan dalam Implementasi Program	43
I. Instrumen Pelaksanaan <i>Peer Educator</i>	44

BAB 3 LITERASI DIGITAL PENCEGAHAN STUNTING 47

A. Konsep Literasi Digital	47
B. Literasi Digital Pencegahan Stunting	54
C. Hasil Literasi Digital Pencegahan Stunting	68

BAB 4 PENGGUNAAN LITERASI DIGITAL DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN REMAJA TERHADAP PENCEGAHAN STUNTING 73

A. Pengetahuan tentang Stunting melalui Metoda <i>Peer Educator</i> Pada Remaja	73
B. Sikap Remaja terhadap Pencegahan Stunting	78

C. Pemeriksaan Hemoglobin pada Remaja.....	80
--	----

BAB 5 PENUTUP	83
----------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA.....	85
----------------------------	-----------

PROFIL PENULIS	91
-----------------------------	-----------

BAB 1

PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang masih menjadi perhatian utama di Indonesia. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi psikososial yang memadai, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan (WHO, 2021). Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki tubuh pendek dibandingkan anak seusianya serta menghadapi risiko penurunan kemampuan kognitif dan produktivitas di masa dewasa (UNICEF, 2022). Di Indonesia, data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2022 menunjukkan bahwa prevalensi stunting masih berada pada angka 21,6% secara nasional, dengan target penurunan hingga 14% pada tahun 2024 (BKKBN, 2022).

Pencegahan stunting membutuhkan pendekatan multidimensional yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk remaja. Remaja, sebagai kelompok usia produktif dan calon orang tua di masa depan, memegang peranan penting dalam mencegah stunting. Sayangnya, pengetahuan remaja terkait gizi, kesehatan reproduksi, serta pola asuh anak masih sering kali rendah (Nasir et al., 2021). Berbagai faktor, termasuk kurangnya edukasi yang relevan dan minimnya akses informasi yang terjangkau, turut memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, pemberdayaan remaja menjadi salah satu strategi kunci dalam upaya menciptakan generasi bebas stunting.

Pendekatan melalui *peer educator* atau pendidik sebaya merupakan salah satu strategi yang efektif dalam pemberdayaan remaja. Metode ini melibatkan remaja untuk saling berbagi informasi dan pengalaman, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima karena disampaikan dalam bahasa dan cara yang sesuai dengan kebutuhan audiens mereka (Bandura, 1986). Penelitian menunjukkan bahwa *peer educator* dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku positif di kalangan remaja, terutama dalam isu-isu kesehatan (Setyawati et al., 2020). Di era digital, pendekatan ini dapat diperkuat dengan literasi digital, yaitu kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara efektif. Remaja saat ini sangat akrab dengan teknologi dan media sosial, sehingga literasi digital menjadi alat yang relevan untuk menyampaikan edukasi secara interaktif dan menarik. Platform digital seperti media sosial, aplikasi pendidikan, dan konten video dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi terkait pencegahan stunting dengan cara yang kreatif dan mudah diakses (Kusuma & Handayani, 2021).

Pendekatan berbasis literasi digital juga memberikan peluang bagi remaja untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi. Selain itu, program ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpikir kritis, yang sangat penting dalam mengatasi tantangan kesehatan masyarakat (Yulianti & Nurhalimah, 2022). Dengan membekali remaja sebagai *peer educator* berbasis literasi digital, mereka tidak hanya berperan sebagai penerima informasi tetapi juga sebagai agen perubahan di lingkungan mereka.

Pemberdayaan remaja melalui *peer educator* berbasis literasi digital menjadi sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia, mengingat penetrasi internet dan penggunaan

media sosial di kalangan remaja yang semakin tinggi. Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), lebih dari 70% remaja di Indonesia aktif menggunakan internet, terutama untuk mengakses media sosial dan mencari informasi (APJII, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja mengenai isu-isu kesehatan, termasuk stunting. Pentingnya Peran Remaja dalam Pencegahan Stunting. Remaja memiliki posisi strategis dalam pencegahan stunting karena mereka adalah calon orang tua di masa depan. Kesehatan remaja, termasuk status gizi dan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, sangat berpengaruh terhadap kondisi anak yang akan mereka lahirkan. Studi menunjukkan bahwa remaja perempuan yang mengalami anemia atau kekurangan gizi memiliki risiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang menjadi salah satu faktor penyebab stunting (UNICEF, 2022). Selain itu, remaja sering kali menjadi panutan bagi lingkungan sekitarnya, terutama dalam kelompok teman sebaya. Dengan memanfaatkan potensi ini, edukasi mengenai pencegahan stunting dapat disebarluaskan secara lebih efektif. Program *peer educator* memberikan ruang bagi remaja untuk berperan aktif dalam menyampaikan informasi dan memotivasi perubahan perilaku di kalangan teman sebaya mereka.

Literasi Digital Alat Inovatif untuk Edukasi Kesehatan. Literasi digital menjadi elemen penting dalam pemberdayaan remaja di era modern. Kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi digital memungkinkan remaja mengakses informasi kesehatan secara mandiri dan memvalidasi kebenarannya. Platform digital seperti video edukasi di YouTube, infografis di Instagram, atau diskusi interaktif melalui aplikasi pesan instan dapat dimanfaatkan

untuk mengedukasi remaja tentang pencegahan stunting secara menarik dan mudah dipahami (Kusuma & Handayani, 2021). Sebagai contoh, penggunaan konten visual seperti infografis atau animasi telah terbukti meningkatkan daya tarik dan pemahaman audiens, terutama remaja. Informasi yang disampaikan melalui media digital juga memiliki potensi untuk menjangkau audiens yang lebih luas dibandingkan pendekatan tradisional seperti seminar atau ceramah (Yulianti & Nurhalimah, 2022).

Relevansi Program Peer Educator di Indonesia. Penerapan program peer educator berbasis literasi digital di Indonesia sejalan dengan kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan akses informasi kesehatan di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan. Selain itu, pendekatan ini dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mencapai target penurunan angka stunting (BPS, 2022). SMK dan SMA menjadi tempat yang ideal untuk mengimplementasikan program ini karena siswa-siswanya berada dalam usia remaja, yang merupakan fase penting untuk membangun pemahaman dan keterampilan hidup. Dengan melibatkan remaja sebagai agen perubahan, program ini juga dapat menciptakan efek berantai di masyarakat, di mana informasi yang mereka sampaikan dapat memengaruhi keluarga dan komunitas mereka secara luas.

Adapun tujuan umum penelitian adalah menganalisis pengaruh penggunaan literasi digital dalam upaya pemberdayaan remaja terhadap pencegahan stunting. Sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai berikut: a) Pembentukan dan pelatihan *peer educator* sebagai bentuk Pemberdayaan Remaja, b) Mengidentifikasi pengetahuan sebelum dan sesudah intervensi pemberian edukasi

menggunakan literasi digital pencegahan stunting oleh *peer educator* pada kelompok perlakuan, c) Mengidentifikasi pengetahuan sebelum dan sesudah intervensi pemberian edukasi menggunakan literasi digital pencegahan stunting oleh *peer educator* pada kelompok control, d) Mengidentifikasi nilai ketrampilan pemeriksaan HB sebelum dan sesudah intervensi pemberian edukasi pada kelompok control, dan e) Mengidentifikasi nilai ketrampilan pemeriksaan HB sebelum dan sesudah intervensi pemberian edukasi pada kelompok kontrol

BAB 2

PEMBERDAYAAN REMAJA PENCEGAHAN STUNTING

A. Konsep Stunting

1. Pengertian Stunting

Stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan kronis pada anak akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Stunting ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan anak seusianya berdasarkan standar pertumbuhan WHO. Kondisi ini juga terkait dengan gangguan perkembangan otak yang dapat memengaruhi kemampuan kognitif, prestasi belajar, dan produktivitas anak di masa depan. Stunting merupakan masalah serius dalam kesehatan anak dan pembangunan sosial-ekonomi. Untuk mengatasi stunting, perlu kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum, dalam upaya meningkatkan gizi dan kesejahteraan anak-anak untuk mencapai pertumbuhan yang optimal.

Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan

sampai awal kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kelahiran) (Kemenkes RI, 2018). Angka stunting Indonesia menurun dari 29 persen pada 2015 menjadi 27,6 persen tahun lalu. Adapun pada 2013 angka stunting nasional mencapai 37,2 persen. Namun angka tersebut masih di atas batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 20 persen.

Masalah stunting merupakan permasalahan gizi yang dihadapi dunia khususnya negara-negara miskin dan berkembang. Stunting merupakan kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai dengan usia 24 bulan. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya kejadian stunting pada balita. Masyarakat belum menyadari stunting sebagai suatu masalah dibandingkan dengan permasalahan kurang gizi lainnya. (Mitra, 2015)

Beberapa poin penting terkait konsep stunting adalah:

Pertumbuhan Terhambat: Stunting ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dari tinggi badan rata-rata anak sebaya. Ini biasanya diukur menggunakan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U). Anak yang mengalami stunting memiliki TB/U lebih rendah dari standar WHO atau kurang dari dua standar deviasi dari rata-rata umur anak tersebut.

Masa Kritis: Kondisi stunting seringkali terjadi pada masa kritis pertumbuhan, yaitu selama periode kehamilan hingga dua tahun pertama kehidupan. Gangguan gizi, terutama kekurangan asupan gizi, selama periode ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada perkembangan fisik dan otak anak.

Dampak Jangka Panjang: Stunting memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan dan perkembangan anak. Anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit kronis, rendahnya produktivitas di kemudian hari, dan gangguan perkembangan kognitif.

Penyebab Stunting: Stunting disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gizi buruk, kekurangan gizi mikro, sanitasi dan kebersihan yang buruk, serta faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan dan akses terbatas pada layanan kesehatan. Pendidikan ibu dan perawatan yang baik selama masa kehamilan dan setelah kelahiran juga berperan penting.

Pencegahan dan Penanganan: Upaya pencegahan stunting melibatkan peningkatan gizi ibu hamil, pemberian makanan gizi kepada anak sejak dini, perbaikan sanitasi dan kebersihan, serta pendidikan gizi. Penanganan stunting pada anak yang sudah mengalami kondisi tersebut perlu melibatkan perawatan medis dan perbaikan pola makan serta gizi.

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh stunting terhadap perkembangan kognitif dan prestasi belajar anak yang dapat menurunkan produktivitas kerja sehingga pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan di suatu negara. Pada kondisi stunting dapat terjadi gangguan pada proses pematangan neuron otak serta perubahan struktur dan fungsi otak yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada perkembangan kognitif. Kondisi ini menyebabkan kemampuan berpikir dan belajar anak terganggu dan pada akhirnya

menurunkan tingkat kehadiran dan prestasi belajar. (Adilla Dwi Nur Yadika, 2019)

2. Penyebab Utama Stunting

Penyebab utama stunting adalah sebagai berikut: 1) Kekurangan Gizi. Asupan gizi yang tidak mencukupi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, selama masa kehamilan hingga usia dua tahun menjadi penyebab utama stunting. Kurangnya protein, kalori, vitamin, dan mineral penting menyebabkan pertumbuhan tubuh dan otak anak terhambat, 2) Pola Asuh yang Tidak Tepat. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai pola asuh, pemberian ASI eksklusif, dan makanan pendamping ASI (MPASI) yang tepat berkontribusi terhadap stunting, 3) Sanitasi Buruk. Lingkungan yang tidak sehat, seperti kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang memadai, meningkatkan risiko infeksi, seperti diare, yang menghambat penyerapan nutrisi, 4) Infeksi Berulang. Penyakit seperti diare, malaria, dan pneumonia dapat memperparah kondisi gizi anak, mengganggu pertumbuhan, dan menyebabkan stunting dan 50 Kemiskinan dan Keterbatasan Akses Kesehatan. Keterbatasan ekonomi sering kali membatasi akses keluarga terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, dan edukasi yang diperlukan untuk mencegah stunting.

3. Dampak Stunting

Stunting berdampak pada berbagai aspek kehidupan anak. Adapaun dampak stunting adalah sebagai berikut: 1) Dampak Fisik; Anak menjadi lebih pendek dibandingkan anak seusianya, dengan risiko lebih tinggi mengalami obesitas dan penyakit kronis di masa dewasa, 2) Dampak Kognitif; Perkembangan otak yang terganggu akibat stunting menyebabkan penurunan

kemampuan belajar, memori, dan kreativitas, dan 3) Dampak Ekonomi dan Sosial; Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki produktivitas rendah saat dewasa, memengaruhi kualitas hidup dan perkembangan ekonomi masyarakat.

B. Pencegahan Stunting

Pencegahan stunting adalah upaya untuk mencegah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi yang kurang selama masa pertumbuhan. Stunting dapat menyebabkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan, perkembangan otak, dan produktivitas seseorang di masa depan.

Berikut adalah beberapa langkah utama untuk mencegah stunting:

1. Asupan Nutrisi yang Baik :

- a. Pada Ibu hamil: Pastikan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang, termasuk zat besi, asam folat, protein, kalsium, dan vitamin D.
- b. Pada Ibu Menyusui: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, lalu lanjutkan dengan MPASI (Makanan Pendamping ASI) bergizi sampai usia 2 tahun.
- c. Pada Anak-anak: Pastikan makanan kaya akan protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral.

2. Pemberian ASI Eksklusif

ASI eksklusif selama 6 bulan pertama memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan bayi, melindungi dari infeksi, dan membantu pertumbuhan optimal.

3. Makanan Pendamping ASI (MPASI)

Mulai MPASI pada usia 6 bulan dengan makanan yang kaya gizi, termasuk sayuran, buah, protein, dan lemak sehat. Dan berikan porsi yang sesuai dengan kebutuhan energi anak.

4. Kebersihan dan Sanitasi

Mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air. Menggunakan air bersih untuk minum dan memasak. Dan menjaga kebersihan lingkungan untuk mengurangi risiko infeksi.

5. Pencegahan dan Penanganan Penyakit

Lakukan imunisasi lengkap sesuai jadwal untuk mencegah penyakit infeksi. Segera obati diare, demam, dan infeksi lainnya agar tidak mengganggu asupan nutrisi anak.

6. Pemeriksaan Kehamilan dan Anak Rutin

Pemeriksaan kehamilan untuk memantau kesehatan ibu dan janin. Dan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara teratur di Posyandu atau layanan kesehatan.

7. Edukasi dan Kesadaran Orang Tua

Edukasi tentang pentingnya gizi, kesehatan, dan stimulasi tumbuh kembang anak. Dan meningkatkan kesadaran akan risiko stunting dan cara mencegahnya.

8. Dukungan Lingkungan dan Kebijakan

Program pemerintah seperti pemberian makanan tambahan, fortifikasi pangan, dan bantuan gizi untuk keluarga berisiko.

Promosi hidup sehat melalui kampanye kesehatan masyarakat.

Sedangkan menurut Kemenkes RI, 2016, pencegahan stunting dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 1) Pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil. Ibu hamil harus mendapatkan makanan yang cukup gizi, suplementasi zat gizi (tablet zat besi atau Fe) dan terpantau kesehatannya. 2) Kepatuhan ibu hamil untuk meminum tablet tambah darah hanya 33 %. Padahal mereka harus minimal mengkonsumsi 90 tablet selama kehamilan, 3) ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dan setelah umur 6 bulan diberi makanan pendamping ASI (MPASI) yang cukup jumlah dan kualitasnya, 4) Memantau pertumbuhan balita di posyandu merupakan upaya yang sangat strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan, 5) Meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan. Sanitasi dan kebersihan untuk pertumbuhan anak yang sempurna intervensi gizi saja belum cukup untuk mengatasi masalah stunting. Faktor sanitasi dan kebersihan lingkungan berpengaruh pula untuk kesehatan ibu hamil dan tumbuh kembang anak, karena anak usia di bawah dua tahun rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit, dan Rendahnya sanitasi dan kebersihan lingkungan pun memicu gangguan saluran pencernaan, yang membuat energi untuk pertumbuhan teralihkan kepada perlawanan tubuh menghadapi infeksi. Sebuah riset menemukan bahwa semakin sering seorang anak menderita diare, maka semakin besar pula ancaman stunting untuknya. (Kemenkes RI, 2016).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan program strategis untuk mencegah dan menurunkan angka stunting, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai target prevalensi stunting

nasional di bawah 14% pada 2024. Berikut adalah beberapa program utama pemerintah dalam pencegahan stunting:

1. Pendekatan Multisektoral

Pemerintah memobilisasi berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bersinergi dalam menurunkan stunting. Sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan infrastruktur berkolaborasi untuk menyediakan layanan dan fasilitas yang mendukung pemenuhan gizi serta pengentasan kemiskinan.

2. Intervensi Spesifik dan Sensitif:

Intervensi spesifik langsung menasar masalah gizi, seperti pemberian makanan tambahan bergizi, suplemen zat besi untuk ibu hamil, tablet tambah darah bagi remaja putri, dan imunisasi lengkap untuk bayi, dan Intervensi sensitif mencakup perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan edukasi gizi untuk ibu hamil dan menyusui

3. Pemantauan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK):

Program ini menekankan pentingnya asupan gizi sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun, periode kritis dalam mencegah stunting. Pemerintah mendukung inisiatif seperti pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama, serta MPASI bergizi setelah enam bulan.

4. Kampanye Edukasi dan Kesadaran:

Pemerintah menggalakkan kampanye melalui media massa dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya stunting. Edukasi ini menargetkan ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga mengenai pentingnya pola makan sehat, sanitasi, serta perilaku hidup bersih.

5. Peningkatan Layanan Kesehatan:

Pemerintah memperluas akses layanan kesehatan di wilayah terpencil melalui puskesmas, posyandu, dan program kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan, dan Upaya ini dilengkapi dengan pemberian suplemen vitamin A, zat besi, dan zinc bagi anak-anak untuk mendukung tumbuh kembang mereka

6. Pengentasan Kemiskinan:

Program pengentasan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), bertujuan membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka. Bantuan ini juga diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap makanan bergizi.

7. Penguatan Kebijakan dan Anggaran:

Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan stunting, baik melalui program kementerian maupun anggaran desa. Dana desa diarahkan untuk mendukung kegiatan posyandu, sanitasi, dan penyediaan air bersih.

Promosi Kesehatan Pencegahan Stunting

Promosi kesehatan adalah salah satu upaya preventif dalam mencegah stunting, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perilaku masyarakat mengenai pentingnya gizi dan faktor lain yang berpengaruh pada pertumbuhan anak. Program ini berfokus pada edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan perubahan perilaku yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Berikut adalah penjelasan mengenai promosi kesehatan dalam pencegahan stunting:

1. Edukasi Masyarakat.

Edukasi menjadi inti dari promosi kesehatan. Kegiatan ini melibatkan penyampaian informasi mengenai: Pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK): Edukasi tentang pentingnya asupan gizi selama kehamilan hingga usia dua tahun untuk mencegah gangguan pertumbuhan, Pola Makan Sehat: Pengetahuan mengenai kebutuhan gizi, termasuk pemberian ASI eksklusif selama enam bulan dan MPASI bergizi sesuai usia, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS): Peningkatan kesadaran tentang kebersihan pribadi dan lingkungan untuk mengurangi risiko infeksi seperti diare yang dapat memicu stunting.

2. Kampanye Sosial. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah

sering melakukan kampanye melalui berbagai media untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, seperti Media Sosial; Penyebaran konten edukatif dalam bentuk infografis, video, dan artikel tentang stunting, dan Program TV dan Radio: Talkshow atau iklan layanan masyarakat yang mengangkat tema gizi dan kesehatan ibu-anak.

3. 3. Pemberdayaan Posyandu dan Kader Kesehatan

Posyandu berperan penting dalam memantau tumbuh kembang anak dan memberikan informasi kepada ibu mengenai: Imunisasi dasar lengkap, Penimbangan berat dan pengukuran tinggi badan untuk deteksi dini risiko stunting, dan Konsultasi tentang pola makan dan pemberian makanan tambahan yang sesuai.

4. Pelatihan bagi Tenaga Kesehatan.

Promosi kesehatan juga melibatkan pelatihan kepada tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, dan kader posyandu untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam; Memberikan konseling gizi kepada ibu hamil dan menyusui, dan Mendeteksi tanda-tanda awal stunting dan memberikan intervensi yang tepat.

5. Melibatkan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan.

Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan program. Promosi kesehatan dilakukan dengan melibatkan: Komunitas Lokal: Mengadakan diskusi kelompok bersama ibu-ibu untuk berbagi pengalaman dan solusi terkait masalah gizi, dan Kemitraan dengan Swasta: Mendukung program CSR perusahaan untuk menyediakan akses pangan bergizi di daerah rentan stunting.

6. 6. Monitoring dan Evaluasi.

Program promosi kesehatan dilengkapi dengan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan-nya dalam mengubah perilaku masyarakat. Data seperti angka stunting, akses gizi, dan sanitasi digunakan untuk mengevaluasi dampak intervensi.

C. Pemberdayaan Remaja

1. Pengertian Pemberdayaan Remaja

Secara umum, pemberdayaan remaja melibatkan pengembangan keterampilan hidup (life skills), pendidikan karakter, dan pelibatan aktif dalam kegiatan yang bermanfaat. Remaja yang diberdayakan diharapkan mampu menjadi pelopor perubahan di lingkungan

mereka, memiliki tanggung jawab sosial, serta berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan. Pemberdayaan remaja adalah proses yang bertujuan untuk membekali remaja dengan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan agar mereka dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab, mengatasi tantangan, serta berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Dalam konteks ini, remaja tidak hanya menjadi objek dari program-program pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam merancang dan melaksanakan perubahan.

2. Tujuan Pemberdayaan Remaja

Tujuan Pemberdayaan Remaja adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan Kemandirian; Membantu remaja mengambil keputusan yang bijaksana dalam hidup mereka, 2) Membangun Kompetensi: Mengembangkan keterampilan dalam bidang tertentu, seperti ekonomi kreatif, teknologi, atau kepemimpinan, 3) Meningkatkan Kepedulian Sosial: Membentuk remaja yang peduli terhadap isu-isu sosial, seperti kesehatan, lingkungan, dan kesetaraan gender, dan 4) Memperkuat Pendidikan Karakter: Menanamkan nilai-nilai moral yang dapat membentuk perilaku positif

Selain itu tujuan Pemberdayaan Remaja adalah: a) Meningkatkan kemandirian: Memberikan remaja kemampuan untuk berpikir kritis, mengambil keputusan, dan bertindak secara mandiri, b) Meningkatkan partisipasi: Mendorong remaja untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi, c) Meningkatkan kapasitas: Membekali remaja dengan keterampilan hidup, pengetahuan tentang isu-isu sosial, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan d) Memperkuat rasa

percaya diri: Membangun kepercayaan diri remaja agar mereka berani menyuarakan pendapat dan memperjuangkan hak-haknya.

3. Strategi Pemberdayaan Remaja

Strategi pemberdayaan remaja sangat penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui pendidikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan minat remaja. Keterampilan ini bisa berupa keterampilan teknis, seperti desain grafis, komputer, atau keterampilan vokasional lainnya, yang membantu mereka untuk memperoleh pekerjaan dan menciptakan peluang ekonomi. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pelatihan keterampilan vokasional memberikan dampak positif terhadap pengurangan angka pengangguran di kalangan remaja (Bappenas, 2020). Program ini dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah, lembaga pendidikan non-formal, atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang bersedia memberikan pelatihan langsung.

Selain itu, pemberdayaan remaja juga bisa dilakukan dengan melibatkan mereka dalam kegiatan sosial dan kepemimpinan. Organisasi kepemudaan atau komunitas lokal dapat menyediakan wadah bagi remaja untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan kerjasama. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Santrock (2019), kegiatan kepemudaan yang melibatkan remaja dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab sosial dapat meningkatkan rasa percaya diri, keterampilan komunikasi, dan kemampuan untuk bekerja dalam tim. Program-program seperti ini memberi

kesempatan kepada remaja untuk terlibat dalam aksi sosial, seperti kegiatan penggalangan dana, bantuan bencana, atau proyek lingkungan, yang sekaligus dapat meningkatkan kesadaran sosial mereka.

Di sisi lain, strategi pemberdayaan yang tak kalah penting adalah pemberian akses yang lebih luas terhadap informasi dan teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, seperti penggunaan platform pembelajaran daring dan aplikasi keterampilan, dapat membuka akses kepada remaja di daerah terpencil untuk memperoleh ilmu dan pengalaman baru. Sebagai contoh, program digitalisasi pendidikan yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia, seperti Program Sekolah Digital, memberikan kesempatan bagi remaja di daerah kurang berkembang untuk mengikuti kursus-kursus online yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang sangat relevan dengan kebutuhan pasar kerja modern (Kemendikbudristek, 2022).

Selain itu, penting untuk memberi ruang bagi remaja untuk mengembangkan potensi diri mereka secara emosional dan mental. Kegiatan berbasis seni dan budaya, seperti seni pertunjukan, musik, atau teater, dapat memberikan cara bagi remaja untuk mengekspresikan diri, mengatasi masalah pribadi, serta meningkatkan kesehatan mental mereka. Hasil penelitian oleh Larson (2000) menunjukkan bahwa kegiatan kreatif seperti ini dapat membantu remaja untuk mengatasi stres dan meningkatkan rasa kebanggaan terhadap diri sendiri.

Melalui berbagai strategi pemberdayaan ini, remaja diharapkan dapat menjadi individu yang tidak hanya siap menghadapi tantangan masa depan, tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat. Keterlibatan

mereka dalam proses pembangunan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya, akan membuka jalan bagi terciptanya masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Strategi Pemberdayaan Remaja dapat dilakukan sebagai berikut: 1) Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R): Program ini memberikan ruang bagi remaja untuk belajar, berkonsultasi, dan berbagi pengalaman. Contohnya, PIK-R di Kampung KB Pelangi di Cianjur yang memadukan pelatihan keterampilan ekonomi seperti budidaya ikan lele, taman baca, dan penyuluhan, 2) Kegiatan Edukasi dan Pelatihan: Pelatihan keterampilan seperti teknologi digital, seni kreatif, hingga pendidikan kesehatan reproduksi membantu remaja memahami isu penting di sekitar mereka, 3) Pelibatan dalam Proyek Sosial: Remaja dilibatkan dalam aksi sosial seperti donor darah, bantuan bencana, dan kampanye antinarkoba. Hal ini memperkuat rasa kepemimpinan dan solidaritas, dan 4) Promosi Kreativitas dan Inovasi: Program seperti "Digital Innovation Challenge" oleh UNICEF Indonesia mendorong remaja untuk menciptakan solusi inovatif terhadap permasalahan komunitas

Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk member-dayakan remaja antara lain: a) Pendidikan non-formal: Melalui kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan keterampilan, dan kelompok diskusi, b) Partisipasi dalam organisasi remaja: Memberikan kesempatan bagi remaja untuk belajar dari teman sebaya dan mengembangkan kepemimpinan, c) Keterlibatan dalam program pemerintah: Memberikan ruang bagi remaja untuk menyampaikan aspirasi dan ide-ide mereka, dan d) Pemanfaatan teknologi informasi: Memanfaatkan media

sosial dan internet sebagai alat untuk berbagi informasi dan berkolaborasi.

4. Dimensi Pemberdayaan Remaja:

Pemberdayaan remaja mencakup beberapa dimensi, antara lain: Pemberdayaan politik: Memberikan kesempatan kepada remaja untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengawasi kinerja pemerintah, Pemberdayaan ekonomi: Membekali remaja dengan keterampilan kewirausahaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi, Pemberdayaan sosial: Mendorong remaja untuk terlibat dalam kegiatan sosial, seperti kerja sukarela, dan membangun jaringan sosial yang positif, dan Pemberdayaan budaya: Memperkuat identitas budaya remaja dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan diri.

5. Manfaat Pemberdayaan Remaja

Pemberdayaan yang efektif menghasilkan remaja yang tidak hanya mandiri, tetapi juga mampu menginspirasi dan memberdayakan orang lain. Program-program seperti PIK-R telah menunjukkan dampak positif dengan meningkatkan keterampilan ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat. Melalui strategi kolaboratif antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan institusi pendidikan, pemberdayaan remaja menjadi langkah penting dalam membangun generasi yang tangguh dan berkualitas di masa depan.

6. Contoh Pemberdayaan Remaja:

Beberapa contoh pemberdayaan remaja adalah sebagai berikut: Program kepemimpinan: Melatih remaja menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan inspiratif, Kelompok diskusi remaja: Memfasilitasi diskusi tentang isu-isu yang relevan dengan remaja, Program

kewirausahaan: Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada remaja yang ingin memulai usaha, Kemitraan dengan organisasi masyarakat: Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat untuk melaksanakan program pemberdayaan remaja.

7. Penilaian Pemberdayaan Remaja

Penilaian pemberdayaan remaja merupakan proses penting dalam mengukur sejauh mana program atau kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan peran aktif remaja dalam masyarakat. Pemberdayaan remaja bertujuan untuk mengembangkan potensi diri remaja agar mereka dapat menjadi individu yang mandiri, kritis, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, penilaian bertujuan untuk menilai efektivitas program yang telah dijalankan serta dampaknya terhadap perubahan perilaku, sikap, dan kemampuan remaja.

Penilaian pemberdayaan remaja dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, antara lain dengan menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif. Pendekatan kualitatif sering kali melibatkan wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, atau observasi langsung untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman, perasaan, dan perubahan yang dirasakan oleh remaja. Di sisi lain, pendekatan kuantitatif lebih berfokus pada pengumpulan data melalui survei atau kuesioner yang dirancang untuk mengukur tingkat keterlibatan, keterampilan, serta pengetahuan remaja sebelum dan sesudah mengikuti program pemberdayaan.

Aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberdayaan remaja mencakup beberapa dimensi

penting, seperti peningkatan kemampuan pribadi, pengembangan keterampilan sosial, pengetahuan tentang isu-isu sosial dan kesehatan, serta kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat. Misalnya, jika suatu program pemberdayaan berfokus pada pendidikan kewirausahaan, maka penilaian akan mencakup sejauh mana remaja dapat mengidentifikasi peluang bisnis, merencanakan usaha, serta mengelola sumber daya yang dimiliki. Selain itu, aspek keterampilan sosial juga penting untuk dinilai, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, dan memecahkan masalah secara kreatif.

Dampak program pemberdayaan remaja juga perlu dianalisis dari perspektif perubahan dalam sikap dan perilaku. Apakah remaja yang terlibat dalam program lebih percaya diri? Apakah mereka lebih aktif dalam kegiatan sosial atau lebih peduli terhadap isu-isu di sekitarnya? Penilaian ini penting untuk mengetahui apakah tujuan jangka panjang dari pemberdayaan, seperti meningkatkan kesadaran sosial atau menciptakan individu yang lebih bertanggung jawab, telah tercapai. Penilaian yang baik juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan program, seperti dukungan keluarga, akses terhadap sumber daya, serta lingkungan sosial di sekitar remaja.

Penilaian pemberdayaan remaja bukan hanya soal mengukur hasil yang bersifat kuantitatif, tetapi juga memahami proses dan perubahan yang terjadi dalam diri remaja. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai keberhasilan suatu program, serta memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan dan pengembangan program di masa yang akan datang. Penilaian yang berkelanjutan dan berbasis pada data yang

valid sangat penting untuk memastikan bahwa upaya pemberdayaan remaja dapat terus beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan yang ada, serta memberi manfaat jangka panjang bagi remaja itu sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.

8. Tantangan dalam Pemberdayaan Remaja

Ada beberapa tantangan dalam pemberdayaan remaja, antara lain: Kurangnya dukungan dari orang tua dan masyarakat: Beberapa orang tua dan masyarakat masih memiliki pandangan tradisional tentang peran remaja, Kurangnya akses terhadap sumber daya: Banyak remaja, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu, tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja, dan Perubahan sosial yang cepat: Perubahan sosial yang cepat dapat membuat remaja merasa bingung dan tidak pasti.

Pemberdayaan remaja merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting. Dengan memberdayakan remaja, kita tidak hanya menciptakan generasi muda yang mandiri dan bertanggung jawab, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.

9. Tantangan Pemberdayaan Remaja dalam Pencegahan Stunting

Tantangan pemberdayaan remaja dalam pencegahan stunting merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Stunting, yang merujuk pada kekurangan gizi kronis yang menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak, merupakan masalah besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Pemberdayaan remaja, terutama remaja perempuan, memainkan peran penting dalam pencegahan stunting, karena mereka akan menjadi ibu di

masa depan. Namun, ada beberapa tantangan signifikan dalam memastikan bahwa upaya pemberdayaan remaja ini dapat efektif dalam mengatasi masalah stunting.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai pentingnya gizi yang baik, terutama terkait dengan pola makan yang sehat sejak usia dini. Di banyak daerah, informasi mengenai gizi yang seimbang dan dampaknya terhadap kesehatan jangka panjang sering kali tidak disampaikan secara memadai. Kurangnya pendidikan kesehatan dan gizi di kalangan remaja menyebabkan mereka tidak memahami hubungan langsung antara kebiasaan makan yang buruk dan risiko stunting pada anak-anak mereka kelak. Tanpa pengetahuan yang cukup, remaja cenderung mengabaikan pola makan yang bergizi dan lebih memilih makanan yang tidak sehat, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada masalah stunting di generasi berikutnya.

Tantangan lain adalah keterbatasan akses terhadap sumber daya dan layanan kesehatan yang memadai. Di daerah-daerah terpencil atau ekonomi yang kurang berkembang, banyak remaja, terutama yang tinggal di keluarga miskin, tidak memiliki akses yang memadai terhadap pangan bergizi, suplemen gizi, atau layanan kesehatan preventif. Faktor ekonomi menjadi penghambat besar dalam pemberdayaan remaja, karena keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar cenderung lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari daripada mengedukasi anak-anak mereka mengenai gizi atau memastikan bahwa mereka menerima makanan yang sehat dan bergizi. Akibatnya, pemberdayaan remaja dalam pencegahan stunting menjadi lebih sulit tercapai.

Selain itu, faktor budaya dan sosial juga memengaruhi pemberdayaan remaja dalam pencegahan stunting. Di beberapa komunitas, peran perempuan masih dianggap terbatas, dan pendidikan untuk mereka tidak selalu diprioritaskan. Hal ini berakibat pada rendahnya kesadaran remaja perempuan tentang pentingnya kesehatan diri sendiri dan keluarga, termasuk pencegahan stunting. Selain itu, pola pikir tradisional dan praktik-praktik budaya tertentu, seperti pemberian makanan yang kurang bergizi atau kepercayaan akan metode pengasuhan yang tidak berdasarkan pada ilmu pengetahuan, bisa memperburuk keadaan. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan remaja juga harus melibatkan perubahan sosial dan budaya yang lebih luas agar informasi mengenai gizi dapat diterima dan diterapkan dengan baik.

Di sisi lain, tantangan pemberdayaan remaja juga berkaitan dengan peran keluarga dan lingkungan sosial. Banyak remaja perempuan yang berada dalam lingkungan keluarga dengan pola asuh yang kurang memadai, sehingga informasi dan dukungan untuk pencegahan stunting sering kali terbatas. Oleh karena itu, pemberdayaan remaja dalam konteks pencegahan stunting tidak hanya melibatkan remaja itu sendiri, tetapi juga keluarga dan masyarakat sekitar. Program pemberdayaan yang berhasil harus melibatkan partisipasi aktif orang tua dan tokoh masyarakat untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pemberdayaan remaja dalam pencegahan stunting menghadapi tantangan besar yang membutuhkan pendekatan holistik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah,

lembaga swadaya masyarakat, serta sektor kesehatan dan pendidikan untuk memberikan informasi yang tepat, meningkatkan akses terhadap gizi yang baik, serta memberdayakan remaja untuk menjadi agen perubahan dalam keluarga dan masyarakat mereka. Dengan cara ini, pencegahan stunting dapat terwujud dengan lebih efektif, memastikan generasi mendatang tumbuh dengan sehat dan memiliki masa depan yang lebih baik.

D. Konsep *Peer Educator*

1. Pengertian *Peer Educator*

Konsep Peer Educator mengacu pada pendekatan di mana individu dari kelompok sebaya (peer) memberikan edukasi, dukungan, atau informasi kepada anggota kelompok sebaya mereka. Peer educator adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman tertentu dan menggunakan hal tersebut untuk memberikan bantuan atau panduan kepada orang lain dalam kelompok sebaya mereka.

Beberapa konsep dasar dalam Peer Educator melibatkan:

Pendekatan Sebaya (Peer Approach): Peer educator bekerja dengan orang yang memiliki karakteristik atau pengalaman serupa. Hal ini dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat dan memungkinkan orang yang menerima edukasi untuk merasa lebih nyaman dan terhubung dengan peer educator.

Pendidikan dan Dukungan: Peer educator bertanggung jawab untuk memberikan informasi atau bantuan kepada kelompok sebaya mereka. Ini dapat melibatkan pendidikan tentang kesehatan, perilaku

tertentu, atau topik lainnya yang relevan dengan kebutuhan kelompok tersebut.

Membangun Kesadaran dan Pemahaman: Peer educator dapat membantu dalam membentuk persepsi dan pemahaman kelompok sebaya terhadap suatu isu atau topik tertentu. Mereka dapat bekerja untuk menghilangkan stigma, memberikan informasi akurat, dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik.

Pemberdayaan (Empowerment): Peer educator tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga bekerja untuk memberdayakan kelompok sebaya mereka. Ini melibatkan pemberian keterampilan dan dukungan yang diperlukan agar individu dapat mengambil kontrol atas hidup mereka sendiri.

Komunikasi Terbuka: Peer educator harus dapat berkomunikasi secara efektif dengan kelompok sebaya mereka. Ini termasuk kemampuan mendengarkan, berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh kelompok tersebut, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran informasi.

Peer educator dapat ditemui dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan formal, kesehatan masyarakat, atau dalam program-program dukungan kelompok. Pendekatan ini mengandalkan kekuatan interaksi sebaya untuk mencapai tujuan pendidikan dan pemberdayaan.

2. Pembentukan *Peer Educator*

Pembentukan *Peer Educator* melibatkan beberapa langkah kunci untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang diperlukan untuk efektif dalam peran mereka.

Berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat diambil dalam proses pembentukan Peer Educator:

a. Identifikasi Tujuan dan Sasaran:

Tentukan tujuan dan sasaran program Peer Educator. Apakah itu terkait dengan kesehatan, pencegahan penyakit, isu-isu sosial, atau topik lainnya? Menetapkan tujuan yang jelas akan membimbing proses pembentukan.

b. Identifikasi Calon Peer Educator:

Identifikasi individu atau anggota kelompok sebaya yang memiliki minat, motivasi, dan karakteristik yang sesuai untuk menjadi Peer Educator. Ini bisa melibatkan pendaftaran sukarelawan atau pemilihan dari dalam kelompok.

c. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan:

Sediakan pelatihan yang komprehensif untuk Peer Educator. Ini dapat mencakup informasi tentang topik yang akan diajarkan, keterampilan komunikasi, pemberdayaan, manajemen pertemuan, dan hal-hal lain yang relevan dengan peran mereka.

d. Mentor dan Pendampingan:

Peer Educator yang baru dibentuk dengan mentor yang berpengalaman. Mentor dapat memberikan panduan, dukungan, dan berbagi pengalaman untuk membantu Peer Educator mengembangkan keterampilan mereka.

e. Pengembangan Materi Pendidikan:

Bantu Peer Educator dalam pengembangan materi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sebaya mereka. Pastikan materi tersebut mudah dipahami, relevan, dan dapat merangsang diskusi.

f. Pilot Program:

Sebelum melibatkan Peer Educator dalam program penuh, lakukan pilot program untuk menguji efektivitas pendekatan dan materi. Ini memberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan sebelum program diluncurkan sepenuhnya.

g. Fasilitasi Pertemuan dan Diskusi:

Latih Peer Educator dalam keterampilan fasilitasi agar mereka dapat memimpin pertemuan dan diskusi dengan efektif. Ini melibatkan cara menyampaikan informasi dengan jelas, memotivasi peserta, dan menjaga keterlibatan kelompok.

h. Evaluasi dan Umpan Balik:

Lakukan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja Peer Educator dan program secara keseluruhan. Terima umpan balik dari anggota kelompok sebaya dan pihak lain yang terlibat untuk terus meningkatkan program.

i. Promosi dan Komunikasi:

Lakukan upaya promosi dan komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa kelompok sebaya tahu tentang keberadaan dan peran Peer Educator. Ini dapat melibatkan pembuatan materi promosi, penggunaan media sosial, atau kegiatan-kegiatan lain yang dapat meningkatkan visibilitas program.

j. Pengakuan dan Apresiasi:

Akui dan hargai kontribusi Peer Educator. Ini dapat mencakup pengakuan publik, sertifikat penghargaan, atau insentif lainnya untuk memotivasi dan mempertahankan partisipasi mereka.

k. Proses pembentukan Peer Educator

perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik kelompok dan konteksnya. Setiap langkah harus

diperhatikan untuk memastikan bahwa Peer Educator memiliki landasan yang kuat dan mendukung untuk menjalankan peran mereka secara efektif.

3. Tujuan Pembentukan *Peer Educator*

Terbentuknya program atau inisiatif Peer Educator memiliki beberapa tujuan utama, yang melibatkan memberikan manfaat kepada kelompok atau individu yang menerima edukasi sebaya.

Beberapa tujuan umum dari pembentukan Peer Educator yaitu:

a. Pendidikan dan Informasi:

Memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada kelompok sebaya tentang topik tertentu, seperti kesehatan, perilaku sehat, pencegahan penyakit, dll.

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kelompok sebaya terhadap isu-isu tertentu.

b. Pencegahan dan Perubahan Perilaku:

Mendorong perubahan perilaku positif dalam kelompok sebaya, seperti mempromosikan gaya hidup sehat, perilaku aman, atau pencegahan penyakit tertentu. Menyampaikan pesan pencegahan dan meminimalkan risiko di antara kelompok sebaya.

c. Pemberdayaan (Empowerment):

Memberdayakan anggota kelompok sebaya untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka.

Membantu mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

- d. Mengurangi Stigma dan Diskriminasi:
Membantu mengurangi stigma yang terkait dengan beberapa isu, seperti masalah kesehatan mental, penyakit menular, atau isu-isu sosial tertentu.
Memainkan peran dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap kelompok atau individu tertentu.
- e. Pengembangan Keterampilan Komunikasi:
Membantu anggota kelompok sebaya untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Mendorong pertukaran informasi terbuka dan positif di antara kelompok sebaya.
- f. Membangun Dukungan Sosial:
Membantu dalam membangun dan memperkuat jejaring sosial di antara anggota kelompok sebaya. Menyediakan dukungan emosional dan praktis di dalam kelompok tersebut.
- g. Mengoptimalkan Pengaruh Kelompok Sebaya:
Memanfaatkan kekuatan interaksi sebaya untuk mencapai hasil positif. Meningkatkan pengaruh positif kelompok sebaya dalam masyarakat.
- h. Pengembangan Keterampilan Kepemimpinan:
Memberikan kesempatan bagi *peer educator* untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka sendiri. Mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional mereka. Penting untuk dicatat bahwa tujuan dari *Peer Educator* dapat bervariasi tergantung pada konteks dan isu yang dihadapi oleh kelompok tertentu. Program ini dirancang untuk merespons kebutuhan spesifik dari kelompok sebaya yang dilibatkan.
Strategi pelatihan untuk *Peer Educator* harus dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan

dukungan yang diperlukan untuk memenuhi peran mereka.

Berikut adalah beberapa strategi pelatihan, alat, dan instrumen yang dapat digunakan:

Strategi Pelatihan:

a. Pelatihan Interaktif:

Gunakan metode pelatihan yang melibatkan peserta secara aktif. Ini bisa termasuk diskusi kelompok, permainan peran, simulasi, dan latihan praktis.

b. Materi Multimedia:

Sediakan materi pelatihan dalam format multimedia, seperti video, presentasi slide, atau animasi. Ini dapat membantu memperjelas konsep dan membuat pelatihan lebih menarik.

c. Studi Kasus:

Gunakan studi kasus untuk menghadirkan skenario kehidupan nyata yang relevan dengan peran Peer Educator. Ini membantu mereka menggabungkan teori dengan praktik.

d. Pelatihan Berbasis Proyek:

Ajak Peer Educator untuk mengembangkan dan melibatkan diri dalam proyek nyata yang terkait dengan tujuan mereka. Ini dapat meningkatkan keterlibatan dan penerapan keterampilan.,

e. Diskusi Terbimbing:

Fasilitasi diskusi terbimbing untuk merangsang pemikiran kritis dan memfasilitasi pertukaran pengalaman di antara Peer Educator,

f. Pendampingan dan Mentorship:

Sediakan pendampingan dan mentorship untuk Peer Educator, mereka dapat belajar dari pengalaman dan wawasan Peer Educator yang lebih berpengalaman,

g. Pelatihan Online:

Gunakan platform pembelajaran online untuk memberikan pelatihan, khususnya jika Peer Educator berada di lokasi yang terpisah. Ini juga dapat memfasilitasi aksesibilitas pelatihan.

Sedangkan Alat Pelatihan adalah:

a. Modul Pelatihan:

Siapkan modul pelatihan yang terstruktur dan mudah diakses, mencakup materi, latihan, dan bahan bacaan.

b. Video Edukasi:

Buat video edukasi yang menggambarkan contoh penerapan keterampilan Peer Educator atau menyajikan informasi kunci.

c. Slide Presentasi:

Siapkan slide presentasi yang menarik dan mudah dipahami untuk membantu penyampaian informasi selama pelatihan.

d. Buku Pedoman:

Sediakan buku pedoman atau panduan yang merinci peran, tanggung jawab, dan prosedur operasional standar bagi Peer Educator.

e. Permainan Pelatihan:

Gunakan permainan pelatihan atau aktivitas kreatif untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif.

Sedangkan Instrumen Evaluasi adalah:

- a. Kuisisioner Pra dan Pasca Pelatihan:
Gunakan kuisisioner untuk mengukur pengetahuan dan sikap Peer Educator sebelum dan setelah pelatihan.
- b. Ujian atau Tes:
Gunakan ujian atau tes pengetahuan untuk mengevaluasi pemahaman materi pelatihan.
- c. Evaluasi Peer:
Mintalah Peer Educator untuk memberikan umpan balik satu sama lain melalui sesi evaluasi kelompok atau kemitraan dengan rekan-rekan mereka.
- d. Observasi Langsung:
Amati Peer Educator saat mereka berpartisipasi dalam simulasi atau menjalankan kegiatan praktis. Ini dapat memberikan wawasan langsung tentang keterampilan mereka.
- e. Refleksi Pribadi:
Ajak Peer Educator untuk melakukan refleksi pribadi tentang pembelajaran mereka, tantangan yang dihadapi, dan rencana pengembangan pribadi.
- f. Wawancara:
Lakukan wawancara dengan Peer Educator untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman pelatihan mereka dan sejauh mana mereka merasa siap untuk peran mereka.

Penting untuk mempersonalisasi strategi pelatihan, alat, dan instrumen sesuai dengan konteks spesifik dan kebutuhan kelompok sebaya yang dilayani oleh Peer Educator. Selain itu, adopsi pendekatan yang berfokus pada partisipasi aktif dan pengalaman langsung dapat membantu meningkatkan efektivitas pelatihan.

E. Tugas *Peer Educator*

Tugas Peer Educator melibatkan berbagai peran dan tanggung jawab yang dirancang untuk memberikan edukasi, dukungan, dan bantuan kepada kelompok sebaya.

Berikut adalah beberapa tugas umum dari seorang Peer Educator: Memberikan Pendidikan dan Informasi: Menyampaikan informasi yang akurat dan relevan kepada kelompok sebaya mengenai topik tertentu, seperti kesehatan, pencegahan penyakit, perilaku sehat, atau isu-isu sosial lainnya, Memfasilitasi Diskusi dan Pertukaran Informasi: Membuka ruang untuk diskusi terbuka dan konstruktif di antara anggota kelompok sebaya. Mendorong pertukaran pengalaman dan informasi antar anggota kelompok.

1. Mengembangkan Materi Pendidikan:

Menyiapkan materi pendidikan yang dapat dipahami dan relevan untuk kelompok sebaya. Menggunakan pendekatan kreatif untuk memfasilitasi pemahaman dan retensi informasi,

2. Pendampingan dan Dukungan:

Memberikan dukungan emosional dan praktis kepada anggota kelompok sebaya yang mungkin menghadapi tantangan atau masalah tertentu. Menjadi pendamping yang dapat diandalkan dan mendengarkan.

3. Pencegahan dan Perubahan Perilaku:

Mendorong perubahan perilaku positif di antara anggota kelompok sebaya. Mengidentifikasi strategi dan taktik yang efektif untuk mendorong perilaku yang diinginkan.

4. Mengorganisir Acara dan Kegiatan:

Merencanakan dan mengorganisir acara, seminar, atau kegiatan lainnya untuk menyampaikan informasi atau memfasilitasi diskusi di antara kelompok sebaya.

5. Mengelola Konflik:

Membantu dalam menangani konflik yang mungkin muncul di antara anggota kelompok sebaya.

6. Memfasilitasi

Resolusi konflik dengan pendekatan yang konstruktif.

7. Advokasi dan Pemberdayaan:

Mengadvokasi kepentingan kelompok sebaya dalam berbagai konteks. Mendorong pemberdayaan anggota kelompok untuk mengambil peran aktif dalam keputusan yang memengaruhi mereka.

Pengembangan Keterampilan: Membantu anggota kelompok sebaya mengembangkan keterampilan tertentu yang relevan dengan tujuan edukasi dan pemberdayaan.

8. Evaluasi dan Pemantauan:

Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program atau kegiatan. Memantau kemajuan dan merespons umpan balik dari anggota kelompok sebaya.

9. Mengelola Informasi Rahasia:

Menjaga kepercayaan dan kerahasiaan informasi pribadi yang mungkin dibagikan oleh anggota kelompok sebaya. Mengikuti etika dan pedoman profesional yang berlaku.

Tugas seorang Peer Educator sangat bervariasi tergantung pada konteksnya, seperti apakah mereka bekerja di bidang kesehatan, pendidikan, atau isu-isu sosial lainnya. Tetapi secara umum, peer educator

berfokus pada memberikan dukungan dan bantuan kepada kelompok sebaya mereka untuk meningkatkan pemahaman, pencegahan, dan pemberdayaan.

F. *Peer Educator* pada Remaja

Peer educator atau pendidik sebaya, adalah pendekatan yang melibatkan remaja sebagai agen penyampai informasi dan pendukung perubahan perilaku di antara teman-teman sebayanya. Pendekatan ini sangat relevan dan efektif karena remaja cenderung lebih mudah menerima informasi dari sesama remaja yang dianggap memiliki pengalaman dan cara berpikir yang serupa. Melalui program *peer educator*, remaja diberdayakan untuk berbagi pengetahuan, memberikan dukungan emosional, dan menjadi teladan perilaku positif dalam komunitas mereka.

Sebagai pendidik sebaya, remaja dilatih untuk menjadi sumber informasi yang andal, fasilitator diskusi, dan motivator yang membantu teman-temannya memahami isu-isu tertentu. Mereka juga berperan sebagai penghubung antara teman sebaya dengan layanan kesehatan atau dukungan profesional lainnya. Hal ini membuat *peer educator* menjadi agen perubahan yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendorong tindakan nyata di kalangan remaja.

Peer educator memiliki beberapa peran utama dalam mendukung perkembangan remaja dan mendorong perilaku positif. Pertama, mereka berperan sebagai penyampai informasi. Dalam peran ini, mereka memberikan penjelasan tentang isu-isu penting dengan cara yang relevan dan mudah dipahami oleh teman sebaya. Misalnya, mereka dapat membahas topik seperti pentingnya kesehatan reproduksi, pencegahan HIV/AIDS, atau bahaya penyalahgunaan

narkoba. Kedua, *peer educator* bertindak sebagai pemberi dukungan emosional. Dalam kehidupan sehari-hari, remaja sering menghadapi berbagai tekanan, seperti konflik dengan teman, tekanan akademik, atau masalah pribadi. Sebagai teman sebaya yang terlatih, *peer educator* dapat menjadi tempat berbagi yang aman dan mendukung teman mereka untuk menghadapi tantangan tersebut. Ketiga, mereka menjadi teladan perilaku positif. *Peer educator* diharapkan dapat menunjukkan pola hidup sehat dan bertanggung jawab yang dapat dicontoh oleh teman-temannya. Dengan menjadi role model, mereka memperkuat pesan yang mereka sampaikan melalui tindakan nyata. Keempat, *peer educator* juga berperan sebagai penghubung. Mereka membantu teman sebaya mendapatkan akses ke layanan kesehatan, konseling, atau sumber daya lain yang diperlukan. Peran ini sangat penting, terutama ketika remaja merasa enggan atau tidak tahu bagaimana cara mengakses layanan tersebut.

Untuk menjadi *peer educator* yang efektif, remaja harus melalui serangkaian pelatihan yang dirancang untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Proses pelatihan biasanya dimulai dengan seleksi, di mana remaja yang memiliki potensi, seperti kemampuan komunikasi yang baik, kepedulian terhadap isu sosial, dan rasa tanggung jawab, dipilih untuk mengikuti program ini. Selanjutnya, para calon *peer educator* diberikan pelatihan intensif. Pelatihan ini mencakup pemahaman mendalam tentang topik-topik yang akan mereka sampaikan, seperti kesehatan reproduksi, gizi, atau kesehatan mental. Selain itu, mereka juga dilatih dalam keterampilan komunikasi, fasilitasi diskusi, dan manajemen konflik. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa

mereka dapat menyampaikan informasi secara efektif dan mampu menangani situasi yang mungkin muncul selama interaksi dengan teman sebaya.

Setelah pelatihan, *peer educator* biasanya mendapatkan pendampingan dari fasilitator atau ahli untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan peran mereka dengan baik. Pendampingan ini juga memberikan kesempatan bagi *peer educator* untuk berkonsultasi dan mendapatkan masukan dalam menghadapi tantangan yang mereka temui di lapangan. Akhirnya, program ini dilengkapi dengan evaluasi untuk menilai dampak kegiatan dan memastikan bahwa tujuan program tercapai.

Pendekatan *peer educator* memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya efektif dalam memengaruhi perilaku remaja. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif. Karena pesan disampaikan oleh sesama remaja, audiens cenderung merasa lebih nyaman dan terbuka untuk menerima informasi. Hubungan setara antara *peer educator* dan teman sebaya juga memungkinkan diskusi yang lebih mendalam dan jujur.

Selain itu, pendekatan ini meningkatkan partisipasi remaja dalam program pendidikan atau intervensi. Remaja cenderung lebih tertarik untuk terlibat dalam kegiatan yang melibatkan teman sebaya mereka dibandingkan dengan program yang dipimpin oleh orang dewasa. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan keterlibatan yang lebih besar di antara peserta.

Keunggulan lainnya adalah dampak jangka panjang terhadap para *peer educator* itu sendiri. Dengan mengikuti program ini, mereka mendapatkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan pengembangan diri yang dapat

digunakan di berbagai aspek kehidupan mereka. Selain itu, mereka juga memperkuat rasa empati dan tanggung jawab sosial yang bermanfaat untuk masa depan.

1. Topik yang Dibahas oleh Peer Educator

Peer educator dapat menyampaikan berbagai topik yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi remaja. Beberapa topik umum yang sering dibahas meliputi:

2. Kesehatan Reproduksi dan Seksual:

Informasi tentang pubertas, menstruasi, kontrasepsi, pencegahan kehamilan tidak diinginkan, dan penyakit menular seksual.

3. Pencegahan Narkoba:

Edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan rokok.

4. Kesehatan Mental:

Membahas pentingnya menjaga kesehatan mental, mengelola stres, dan mengenali tanda-tanda depresi.

5. Pencegahan Bullying:

Mengajarkan cara menghadapi bullying dan menciptakan lingkungan yang saling mendukung.

6. Pengembangan Diri:

Pendidikan karakter, keterampilan kepemimpinan, dan manajemen waktu.

G. Dampak Positif Peer Educator

Program peer educator telah terbukti memberikan dampak positif baik bagi individu maupun komunitas. Dalam konteks individu, remaja yang terlibat sebagai peer educator mengalami peningkatan pengetahuan, keterampilan sosial, dan rasa percaya diri. Mereka juga menjadi lebih sadar akan pentingnya perilaku sehat dan bertanggung jawab.

Bagi komunitas, program ini membantu meningkatkan kesadaran tentang isu-isu penting dan mendorong perubahan perilaku positif di kalangan remaja. Misalnya, program peer educator tentang kesehatan reproduksi dapat mengurangi angka kehamilan remaja atau penyebaran penyakit menular seksual. Selain itu, pendekatan ini juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif bagi remaja.

H. Tantangan dalam Implementasi Program

Implementasi program peer educator juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan akan pelatihan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa peer educator tetap mendapatkan informasi yang akurat dan relevan. Selain itu, beberapa remaja mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalankan peran mereka karena kurangnya dukungan dari teman sebaya atau orang dewasa di sekitar mereka.

Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa program ini dapat menjangkau semua kelompok remaja, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau berasal dari latar belakang yang kurang mampu. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, sekolah, dan komunitas.

Peer educator adalah pendekatan yang efektif untuk memberdayakan remaja dalam mendukung perubahan perilaku positif di komunitas mereka. Dengan melibatkan remaja sebagai agen perubahan, program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran tentang isu-isu penting, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi para peserta. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, dengan

dukungan yang tepat, pendekatan peer educator dapat menjadi alat yang kuat untuk menciptakan generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan bertanggung jawab.

I. Instrumen Pelaksanaan *Peer Educator*

Instrumen pelaksanaan program Peer Educator atau pendidik sebaya merupakan alat penting dalam menyukseskan berbagai program pendidikan, terutama yang berfokus pada remaja. Peer educator adalah individu yang terlatih untuk menyampaikan informasi, berbagi pengetahuan, dan memberi dukungan kepada teman sebaya mereka. Model pendidikan ini memanfaatkan pendekatan berbasis interaksi antar-remaja, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai isu-isu penting seperti kesehatan reproduksi, gizi, pencegahan penyakit, hingga stunting. Instrumen pelaksanaan program ini melibatkan berbagai komponen yang harus direncanakan dan dijalankan dengan cermat agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Salah satu instrumen pertama yang harus disiapkan adalah pelatihan bagi para peer educator. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para remaja dengan pengetahuan yang memadai tentang topik yang akan mereka sampaikan, misalnya mengenai pencegahan stunting, pola makan sehat, atau pentingnya kebersihan. Pelatihan ini juga mencakup keterampilan komunikasi yang efektif, teknik penyuluhan, serta keterampilan dalam mendengarkan dan memberikan dukungan emosional. Peer educator harus dilatih untuk menjadi fasilitator yang tidak hanya mengedukasi, tetapi juga mampu membangun hubungan yang positif dan terbuka dengan teman sebaya mereka.

Instrumen kedua yang diperlukan adalah materi pendidikan yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh remaja. Materi ini harus disesuaikan dengan karakteristik usia dan budaya remaja yang menjadi sasaran program. Misalnya, materi mengenai stunting harus menjelaskan dengan jelas penyebab, dampak, serta cara pencegahannya, dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari remaja. Selain itu, materi juga harus mencakup studi kasus atau contoh nyata yang bisa dihubungkan dengan pengalaman hidup mereka, sehingga dapat lebih mudah diterima dan diterapkan.

Selanjutnya, instrumen penting lainnya adalah metode dan teknik penyuluhan yang digunakan dalam pelaksanaan program. Peer educator harus mampu mengadaptasi metode yang bervariasi agar dapat menjangkau audiens dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Beberapa metode yang bisa digunakan antara lain diskusi kelompok, role play (permainan peran), atau penggunaan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan pesan secara lebih luas dan efektif. Interaksi yang terbuka dan partisipatif juga sangat diperlukan agar remaja merasa nyaman untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman.

Evaluasi dan monitoring juga merupakan instrumen yang sangat penting dalam pelaksanaan program peer educator. Setiap kegiatan yang dilakukan harus dievaluasi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui kuesioner, wawancara, atau diskusi kelompok terfokus yang melibatkan remaja sebagai peserta. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa peer educator tetap melaksanakan tugas

mereka dengan baik dan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses pendidikan.

Selain itu, penting juga untuk memastikan adanya dukungan dari pihak yang lebih berwenang, seperti guru, tenaga kesehatan, atau orang tua, yang dapat memperkuat keberhasilan program. Keterlibatan mereka dalam memberikan dukungan atau supervisi kepada para peer educator sangat penting untuk memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan prinsip yang benar dan mendukung tercapainya tujuan program.

BAB 3

LITERASI DIGITAL PENCEGAHAN STUNTING

A. Konsep Literasi Digital

1. Pengertian Literasi Digital

Literasi digital mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang diperlukan seseorang untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan efektif. Ini mencakup kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital.

Berikut adalah beberapa konsep kunci dalam literasi digital:

- a. **Pemahaman Teknologi:** Kemampuan untuk menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Memahami bagaimana teknologi bekerja dan berinteraksi.
- b. **Evaluasi Informasi:** Kemampuan untuk menilai keandalan dan kredibilitas informasi digital. Memahami konsep berita palsu (hoax) dan kemampuan untuk mengidentifikasinya.
- c. **Pemahaman Privasi dan Keamanan:** Kesadaran akan pentingnya melindungi data pribadi. Memahami konsep dasar keamanan online dan praktik-praktik aman.
- d. **Kemampuan Penelusuran dan Penemuan Informasi:** Kemampuan untuk mencari informasi dengan efektif

menggunakan mesin pencari dan sumber daya online. Menguasai keterampilan penelusuran informasi yang baik.

- e. Kemampuan Berkomunikasi: Mampu berkomunikasi secara efektif melalui berbagai platform digital. Pemahaman etika berkomunikasi online.
- f. Kemampuan Kritis dan Analitis: Kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi secara kritis. Mampu memahami implikasi sosial, ekonomi, dan politik dari informasi digital.
- g. Pemahaman Hak dan Tanggung Jawab Hukum: Mengetahui hak dan tanggung jawab hukum yang terkait dengan penggunaan teknologi. Pemahaman etika digital dan aturan hukum yang berkaitan.
- h. Kemampuan Penyelesaian Masalah: Kemampuan untuk mengatasi masalah teknis dan non-teknis yang mungkin muncul dalam penggunaan teknologi digital. Kreativitas dalam mencari solusi.
- i. Kemampuan Adaptasi: Kesadaran akan perubahan dalam teknologi dan mampu beradaptasi dengan cepat. Keterampilan untuk terus belajar dan mengembangkan literasi digital seiring waktu.

2. Bentuk Literasi Digital:

- a. Teknologi Komputer dan Perangkat Lunak: Kemampuan menggunakan perangkat keras (komputer, tablet, ponsel) dan perangkat lunak (aplikasi, program).
- b. Internet dan Penelusuran Informasi: Keterampilan mencari informasi secara efektif menggunakan mesin pencari dan menjelajahi internet.
- c. Evaluasi Informasi: Kemampuan menilai keandalan dan kredibilitas informasi dari sumber digital.

- d. Keamanan dan Privasi: Kesadaran dan tindakan untuk melindungi privasi online serta penerapan praktik keamanan digital.
- e. Kemampuan Komunikasi Digital: Mampu berkomunikasi melalui email, pesan instan, media sosial, dan platform komunikasi digital lainnya.
- f. Media Sosial: Pemahaman dan keahlian dalam menggunakan media sosial dengan etika yang benar.
- g. Analisis Data dan Statistik: Kemampuan memahami dan menganalisis data serta informasi statistik yang ditemui online.
- h. Hak dan Tanggung Jawab Hukum: Pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum yang terkait dengan aktivitas online.

3. Kegunaan dan Manfaat Literasi Digital:

- a. Partisipasi Aktif dalam Masyarakat Digital: Memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang semakin didominasi oleh teknologi.
- b. Akses ke Informasi: Membuka akses lebih luas terhadap berbagai sumber informasi dan pengetahuan melalui internet.
- c. Peningkatan Produktivitas: Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari.
- d. Komunikasi Efektif: Memfasilitasi komunikasi yang efektif dan cepat dengan orang-orang di seluruh dunia.
- e. Kreativitas dan Inovasi: Mendorong kreativitas dan inovasi melalui penggunaan berbagai alat dan platform digital.
- f. Kewirausahaan Digital: Membuka peluang untuk mengembangkan bisnis dan proyek secara online.

- g. Pendidikan Daring: Memungkinkan akses ke pembelajaran online dan sumber daya pendidikan digital.

4. Kegunaan Literasi Digital dalam Pelatihan:

- a. Peningkatan Efektivitas Pembelajaran: Memungkinkan penggunaan berbagai sumber daya dan metode pembelajaran digital untuk meningkatkan efektivitas pelatihan.
- b. Adaptasi Terhadap Teknologi Baru: Memastikan bahwa peserta pelatihan dapat dengan cepat beradaptasi dengan teknologi baru yang mungkin digunakan dalam konteks pekerjaan mereka.
- c. Kemampuan untuk Mempelajari Mandiri: Memfasilitasi kemampuan peserta pelatihan untuk belajar mandiri melalui sumber daya online.
- d. Pengembangan Keterampilan Kerja: Mendorong pengembangan keterampilan digital yang relevan dengan pekerjaan atau industri tertentu.
- e. Interaksi dan Kolaborasi Online: Memfasilitasi interaksi dan kolaborasi online di antara peserta pelatihan, menciptakan pengalaman belajar yang lebih kolaboratif.
- f. Edukasi terkait Etika Digital: Menyertakan aspek literasi digital yang berkaitan dengan etika dalam konteks pelatihan.

Pemahaman dan penerapan literasi digital bukan hanya keahlian yang penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di berbagai sektor. Literasi digital dapat memainkan peran yang signifikan dalam upaya pencegahan stunting pada remaja. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada anak

akibat kekurangan gizi kronis, dan remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan termasuk stunting.

Berikut adalah beberapa cara literasi digital dapat berkontribusi dalam pencegahan stunting pada remaja:

- a. Edukasi Gizi Digital: Literasi digital dapat digunakan untuk menyebarkan informasi gizi yang benar dan berguna melalui platform online, situs web, dan media sosial. Kampanye literasi digital dapat membantu remaja memahami pentingnya asupan gizi yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal.
- b. Akses Informasi Kesehatan: Memperluas akses remaja terhadap informasi kesehatan dan gizi melalui sumber daya digital seperti aplikasi kesehatan, situs web tepercaya, dan materi edukasi online. Mempromosikan penggunaan teknologi sebagai alat untuk mencari solusi dan informasi kesehatan yang tepat.
- c. Pengenalan Resep Gizi Seimbang: Memberikan panduan digital untuk menyusun dan memasak makanan bergizi dengan mudah dan terjangkau. Mengajarkan remaja melalui platform online tentang pilihan makanan seimbang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka.
- d. Penggunaan Aplikasi Pemantauan Pertumbuhan: Mengenalkan aplikasi kesehatan dan pemantauan pertumbuhan yang dapat membantu remaja dan orang tua memantau perkembangan fisik dan kesehatan anak. Mendorong penggunaan teknologi untuk mencatat pola makan dan pertumbuhan anak.
- e. Program Pendidikan Gizi Digital: Mengembangkan program pendidikan gizi digital yang interaktif dan menarik untuk remaja. Mendorong partisipasi aktif

melalui platform online, termasuk kelas virtual, webinar, dan forum diskusi.

- f. Kampanye Literasi Digital dan Gizi: Melakukan kampanye literasi digital yang fokus pada gizi, termasuk cara membaca dan memahami informasi gizi pada label makanan digital. Memberikan keterampilan literasi digital yang memungkinkan remaja menyaring informasi gizi yang dapat diandalkan dari sumber online.
- g. Penggunaan Media Sosial untuk Kampanye Kesehatan: Menciptakan kampanye kesehatan melalui media sosial yang menargetkan remaja dengan pesan-pesan positif tentang pola makan sehat dan pertumbuhan optimal. Mengajak remaja untuk berbagi informasi dan pengalaman mereka dalam mencapai pola makan seimbang.

Melibatkan remaja dalam literasi digital yang terfokus pada aspek gizi dapat membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pola makan seimbang dan dampaknya terhadap pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dengan memanfaatkan teknologi digital, upaya pencegahan stunting pada remaja dapat menjadi lebih efektif dan terjangkau.

Penggunaan literasi digital tentang stunting oleh remaja dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti akses teknologi, pendidikan, dan budaya setempat.

Beberapa kemungkinan dampak dan tren terkait penggunaan literasi digital dalam pemahaman remaja tentang stunting melibatkan:

- a. Aksesibilitas: Remaja yang memiliki akses lebih baik terhadap teknologi digital, seperti ponsel pintar dan internet, mungkin lebih cenderung menggunakan literasi digital untuk memperoleh informasi tentang stunting. Di daerah-daerah dengan konektivitas yang baik, penggunaan literasi digital bisa lebih luas.
- b. Sumber Informasi yang Diversifikasi: Literasi digital memungkinkan remaja untuk mengakses berbagai sumber informasi tentang stunting, termasuk artikel, video edukatif, infografis, dan sumber daya multimedia lainnya. Hal ini dapat membantu menyajikan informasi dengan cara yang menarik dan bervariasi.
- c. Partisipasi dalam Kampanye Edukasi Digital: Sejumlah kampanye edukasi digital dapat memanfaatkan literasi digital untuk menyebarkan informasi tentang stunting. Melalui media sosial, situs web edukatif, atau platform digital lainnya, remaja dapat terlibat dalam kampanye tersebut dan menyebarkan pesan pencegahan stunting.
- d. Keterlibatan Aktif dalam Komunitas Online: Remaja cenderung terlibat dalam komunitas online yang berkaitan dengan minat atau masalah tertentu. Dalam konteks literasi digital tentang stunting, mereka dapat bergabung dalam forum atau grup online yang membahas isu-isu kesehatan dan gizi, termasuk pencegahan stunting.
- e. Pembelajaran Kolaboratif: Literasi digital memungkinkan remaja untuk terlibat dalam pembelajaran kolaboratif, di mana mereka dapat berbagi informasi dan pengalaman dengan sesama mereka. Ini menciptakan lingkungan di mana

pengetahuan tentang stunting dapat berkembang melalui interaksi sosial online.

- f. Tantangan Akses dan Literasi Digital: Sementara sebagian besar remaja mungkin memiliki akses ke teknologi digital, masih ada tantangan terkait literasi digital. Beberapa remaja mungkin tidak terampil dalam mengevaluasi keandalan informasi online atau mungkin tidak tahu cara menggunakan teknologi digital secara efektif untuk memahami isu-isu kesehatan.
- g. Penggunaan Aplikasi Kesehatan dan Kesejahteraan: Beberapa aplikasi kesehatan dan kesejahteraan dapat memberikan informasi tentang stunting dan memberikan saran praktis tentang pola makan sehat. Remaja yang aktif menggunakan aplikasi semacam itu dapat lebih mudah memahami pentingnya gizi yang baik.

B. Literasi Digital Pencegahan Stunting

Literasi digital dapat memainkan peran krusial dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk pencegahan stunting pada remaja.

Berikut adalah beberapa cara di mana literasi digital dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan stunting:

1. Akses Informasi: Pengetahuan:

Literasi digital memungkinkan remaja untuk mengakses informasi kesehatan dan gizi yang akurat dan terkini secara online. Sikap: Membantu membentuk sikap positif terhadap pencarian informasi kesehatan dan kebiasaan hidup sehat.

2. Media Sosial dan Kampanye Edukasi: Pengetahuan:

Literasi digital memungkinkan remaja untuk mengikuti kampanye edukasi kesehatan dan gizi melalui media sosial. Sikap: Mendorong partisipasi aktif dalam kampanye dan berbagi informasi positif tentang gizi dan pertumbuhan anak.

3. Aplikasi Kesehatan dan Nutrisi: Keterampilan:

Literasi digital membantu remaja menggunakan aplikasi kesehatan dan nutrisi untuk memantau asupan makanan, pertumbuhan, dan kesehatan mereka. Sikap: Membentuk sikap proaktif terhadap penggunaan teknologi sebagai alat untuk pemantauan kesehatan pribadi.

4. Pendidikan Daring: Pengetahuan:

Literasi digital memfasilitasi akses ke sumber daya pendidikan daring tentang gizi dan kesehatan. Sikap: Mendorong sikap terbuka terhadap pembelajaran mandiri dan peningkatan pengetahuan kesehatan melalui platform online.

5. Kemampuan Evaluasi Informasi: Keterampilan:

Literasi digital membantu remaja dalam menilai dan memilih informasi kesehatan yang dapat dipercaya dari berbagai sumber online. Sikap : me-ngembangkan sikap kritis terhadap informasi, menghindari penyebaran informasi palsu atau tidak akurat.

6. Interaksi dengan Komunitas Daring:

Pengetahuan: Melalui forum online dan grup diskusi, remaja dapat berinteraksi dengan komunitas dan mendapatkan informasi dari pengalaman orang lain. Sikap: Mendorong rasa kebersamaan dan dukungan antarremaja terkait dengan praktik gizi sehat.

7. Kampanye Literasi Gizi Digital:

Pengetahuan: Kampanye literasi digital dapat menyampaikan informasi kesehatan dan gizi secara menarik melalui media digital. Sikap: Meningkatkan kesadaran dan minat remaja terhadap topik kesehatan dan nutrisi.

8. Pemanfaatan Teknologi untuk Pelatihan:

Keterampilan: Remaja dapat mengembangkan keterampilan penggunaan aplikasi dan teknologi terkait kesehatan dan nutrisi. Sikap: Meningkatkan motivasi untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pendidikan kesehatan digital.

Penerapan literasi digital dalam konteks pencegahan stunting pada remaja dapat menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan pengetahuan, sikap positif, dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimal. Dengan memanfaatkan teknologi dengan bijak, remaja dapat menjadi agen perubahan dalam mengadopsi gaya hidup sehat dan mencegah stunting.

Literasi digital memberikan remaja akses mudah ke informasi kesehatan, termasuk pencegahan stunting.

Berikut adalah cara remaja dapat menggunakan literasi digital untuk mengakses informasi kesehatan terkait pencegahan stunting:

1. Pencarian Online:

Remaja dapat menggunakan mesin pencari untuk mencari informasi terkait gizi, pola makan sehat, dan cara pencegahan stunting. Situs web resmi organisasi kesehatan, lembaga pemerintah, atau badan internasional menyediakan sumber informasi yang dapat dipercaya.

2. Aplikasi Kesehatan:

Mengunduh dan menggunakan aplikasi kesehatan yang menyediakan informasi tentang nutrisi, pertumbuhan anak, dan panduan pencegahan stunting. Beberapa aplikasi juga dapat memberikan peringatan dan saran berdasar-kan informasi pribadi tentang pola makan dan kesehatan anak.

3. Sosial Media:

Mengikuti akun media sosial yang menyediakan konten edukatif tentang kesehatan dan gizi. Terlibat dalam diskusi dan kampanye online terkait pencegahan stunting untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif.

4. Pendidikan Daring:

Mengikuti kursus daring atau webinar tentang gizi, pertumbuhan anak, dan strategi pencegahan stunting. Pendidikan daring memberikan fleksibilitas bagi remaja untuk belajar sesuai dengan waktu luang mereka.

5. Forums dan Komunitas Daring:

Bergabung dengan forum daring atau grup komunitas yang membahas topik kesehatan dan nutrisi. Bertukar informasi, pengalaman, dan saran dengan orang-orang sebaya dan profesional kesehatan.

6. Podcast dan Video Edukatif:

Mendengarkan podcast atau menonton video edukatif di platform seperti YouTube yang menyajikan informasi tentang pencegahan stunting. Format audio atau visual dapat membuat informasi lebih menarik dan mudah dipahami.

7. Akses ke Riset dan Artikel Ilmiah:

Mempelajari artikel ilmiah dan riset terbaru tentang gizi dan pencegahan stunting melalui repositori digital,

jurnal ilmiah, atau situs web pemerintah yang menyediakan informasi terkini.

8. Penggunaan Aplikasi Pemantauan Kesehatan:

Menggunakan aplikasi pemantauan kesehatan yang menyediakan panduan khusus untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Aplikasi ini dapat memberikan informasi kesehatan pribadi dan merekomendasikan langkah-langkah pencegahan stunting.

Dengan memanfaatkan literasi digital, remaja dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang pentingnya gizi dan kesehatan dalam pencegahan stunting. Penting untuk mengajarkan remaja untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan kritis untuk mendapatkan informasi yang akurat dan bermanfaat.

Peran remaja dalam pencegahan stunting sangat penting karena mereka merupakan bagian dari kelompok usia yang mengalami pertumbuhan pesat dan perkembangan. Upaya pencegahan stunting yang melibatkan remaja dapat memiliki dampak positif dalam jangka panjang.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa remaja memiliki peran yang penting dalam pencegahan stunting:

1. Pembentukan Kebiasaan Hidup Sehat:

Remaja yang mendapatkan pemahaman tentang gizi yang baik dan pola makan sehat dapat membentuk kebiasaan ini untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka di masa depan.

2. Pengambilan Keputusan Pribadi:

Remaja yang terlatih secara kesehatan akan lebih mampu membuat keputusan yang baik terkait makanan dan pola hidup sehat.

3. Pendukung Keluarga:

Remaja yang memiliki pengetahuan tentang gizi dapat menjadi pendukung dalam keluarga mereka, membagikan informasi dengan orang tua dan adik-adik mereka.

4. Pendidikan Sebaya:

Remaja dapat membantu menyebarkan informasi penting tentang gizi dan pencegahan stunting di antara teman sebayanya melalui kampanye pendidikan sebaya.

5. Pembawa Perubahan:

Remaja yang teredukasi tentang stunting dan masalah kesehatan terkait dapat menjadi pembawa perubahan di masyarakat, mendorong kesadaran dan perubahan perilaku.

6. Partisipasi dalam Program Kesehatan:

Remaja dapat aktif berpartisipasi dalam program-program kesehatan yang ditujukan untuk pendidikan gizi dan pencegahan stunting di sekolah atau komunitas mereka.

7. Penciptaan Lingkungan yang Sehat:

Remaja dapat berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat, termasuk mengkampanyekan kantin sekolah yang menyediakan makanan sehat.

8. Peran sebagai Model Perilaku:

Remaja yang menunjukkan pola makan dan gaya hidup sehat dapat menjadi model perilaku positif bagi teman-teman sebaya dan anggota keluarga mereka.

9. Partisipasi dalam Riset dan Inovasi:

Remaja yang berminat dalam riset dan inovasi dapat berperan dalam mencari solusi baru untuk meningkatkan gizi dan mencegah stunting.

10. Advokasi untuk Perubahan Kebijakan:

Remaja yang terlibat dalam advokasi dapat memperjuangkan perubahan kebijakan yang mendukung gizi dan kesehatan anak-anak, termasuk pencegahan stunting.

11. Penggunaan Teknologi untuk Pendidikan

Kesehatan:

Remaja dapat menggunakan literasi digital untuk mengakses dan menyebarkan informasi kesehatan, menyelenggarakan kampanye daring, dan memanfaatkan teknologi untuk pendidikan kesehatan.

Melibatkan remaja dalam upaya pencegahan stunting tidak hanya membawa manfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk kesehatan dan kesejahteraan generasi mendatang. Penting untuk memberikan pendidikan kesehatan yang komprehensif dan memberdayakan remaja untuk berperan aktif dalam mendorong perubahan positif dalam perilaku dan lingkungan sekitar mereka.

Remaja dapat melakukan berbagai kegiatan yang dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan stunting. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh remaja:

1. Kampanye Pendidikan Sebaya:

Mengorganisir kampanye di sekolah atau komunitas mereka untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi dan pencegahan stunting. Menggunakan presentasi, poster, dan materi edukasi kreatif untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik.

2. Pelatihan Gizi dan Kesehatan:

Mengadakan sesi pelatihan gizi di sekolah atau pusat komunitas untuk remaja dan keluarga mereka. Melibatkan profesional kesehatan atau ahli gizi untuk memberikan informasi yang akurat.

3. Kampanye Media Sosial:

Membuat dan menyebarkan konten di media sosial yang berkaitan dengan gizi, pola makan sehat, dan pencegahan stunting. Mendorong penggunaan tagar atau hashtag khusus untuk kampanye mereka.

4. Partisipasi dalam Program Pendidikan Gizi:

Bergabung dalam program pendidikan gizi di sekolah atau pusat kesehatan untuk mendapatkan pengetahuan lebih lanjut dan mendukung upaya pencegahan stunting.

5. Sesi Diskusi dan Kelompok Studi:

Mengadakan sesi diskusi atau kelompok studi dengan teman sebaya untuk membahas topik kesehatan dan gizi. Mempromosikan pertukaran ide dan informasi positif.

6. Kampanye Gizi di Sekolah:

Mengusulkan atau berpartisipasi dalam kampanye gizi di sekolah untuk meningkatkan ketersediaan makanan sehat di kantin dan promosi gaya hidup sehat.

7. Penyuluhan untuk Orang Tua dan Masyarakat:

Mengorganisir kegiatan penyuluhan untuk orang tua dan masyarakat tentang gizi dan pencegahan stunting. Menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami dan relevan.

8. Pembuatan Materi Pendidikan:

Membuat materi edukasi, seperti brosur, pamflet, atau video, yang dapat dibagikan kepada teman sebaya,

keluarga, dan masyarakat. Menyusun informasi dengan bahasa yang sesuai dengan audiens target.

9. Aksi Sosial:

Terlibat dalam kegiatan aksi sosial yang berfokus pada kesehatan anak dan pencegahan stunting, seperti penggalangan dana atau kegiatan sukarela di lembaga amal.

10. Penggunaan Teknologi untuk Kampanye Kesehatan:

Membuat konten pendidikan kesehatan di platform daring, seperti blog, vlog, atau podcast. Menyebarkan informasi melalui aplikasi pesan, grup diskusi, atau platform media sosial.

11. Partisipasi dalam Penelitian atau Inisiatif Inovatif:

Melibatkan diri dalam penelitian atau inisiatif inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang stunting dan mencari solusi yang efektif.

Melibatkan remaja dalam kegiatan pencegahan stunting dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam komunitas mereka. Dengan membentuk pemahaman dan kesadaran yang baik, remaja dapat menjadi agen perubahan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara optimal.

Peer tutor atau tutor sebaya dapat menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam upaya pencegahan stunting pada remaja.

Berikut adalah beberapa cara di mana peer tutor dapat memberikan kontribusi yang positif:

1. Komunikasi Lebih Terbuka:

Remaja mungkin merasa lebih nyaman dan lebih terbuka untuk berbicara dengan sesama remaja dibandingkan dengan figur otoritas seperti guru atau profesional kesehatan. Peer tutor dapat menciptakan

lingkungan yang mendukung pertukaran informasi dan pengalaman.

2. Relatabilitas dan Identifikasi:

Peer tutor, sebagai rekan sebaya, mungkin memiliki pengalaman yang lebih mudah diidentifikasi oleh remaja yang sedang belajar tentang kesehatan dan nutrisi. Mereka dapat berbagi pengalaman pribadi atau cara mereka mengatasi tantangan serupa.

3. Pendidikan Sebaya:

Peer tutor dapat memberikan pendidikan sebaya, di mana mereka membantu teman sebayanya untuk memahami konsep-konsep kesehatan, gizi, dan pencegahan stunting. Mereka dapat memfasilitasi diskusi, sesi tanya jawab, dan kegiatan kelompok.

4. Pendekatan yang Lebih Menyenangkan dan Interaktif:

Peer tutor dapat menggunakan pendekatan yang lebih menyenangkan dan interaktif dalam menyampaikan informasi, seperti permainan, kuis, atau demonstrasi praktis. Ini dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dicerna.

5. Meningkatkan Kepercayaan Diri:

Dengan menjadi peer tutor, remaja dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menyampaikan informasi dan memberikan dampak positif pada teman-teman sebayanya. Proses pembelajaran ini juga dapat memberikan pengalaman kepemimpinan.

6. Model Perilaku Positif:

Peer tutor dapat berperan sebagai model perilaku positif terkait dengan pola makan sehat dan gaya hidup aktif. Melalui contoh langsung, mereka dapat memotivasi

teman-teman sebayanya untuk mengadopsi kebiasaan hidup yang lebih sehat.

7. Mendukung Implementasi Perubahan Perilaku:

Peer tutor dapat membantu dalam merencanakan dan mendukung teman-teman sebayanya dalam mengimplementasikan perubahan perilaku positif terkait gizi dan kesehatan. Mereka dapat memberikan dukungan dan motivasi.

8. Membangun Solidaritas Kelompok:

Peer tutor dapat membantu membangun solidaritas dan rasa saling peduli di antara kelompok remaja. Ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung adopsi kebiasaan hidup sehat secara bersama-sama.

9. Pendekatan Kontekstual:

Peer tutor, karena mereka memiliki pemahaman mendalam tentang lingkungan dan konteks sosial remaja, dapat menyusun pendekatan yang lebih sesuai dan kontekstual dalam menyampaikan informasi pencegahan stunting.

10. Mendorong Partisipasi Aktif:

Dengan melibatkan remaja sebagai peer tutor, ada kemungkinan lebih besar untuk meningkatkan partisipasi aktif dan keterlibatan teman sebaya dalam kegiatan pencegahan stunting.

Untuk memberikan pelatihan yang memadai kepada peer tutor dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan pedoman kesehatan yang benar. Dengan pemilihan dan pelatihan yang tepat, peer tutor dapat menjadi aset berharga dalam menggalakkan pencegahan stunting di kalangan remaja.

Peer educator yang terlatih dapat berperan penting dalam membantu remaja menggunakan literasi digital dalam upaya pencegahan stunting.

Berikut adalah beberapa cara di mana *peer educator* dapat mendukung remaja dalam memanfaatkan literasi digital untuk pencegahan stunting:

1. Pelatihan Literasi Digital:

Peer educator dapat memberikan pelatihan literasi digital kepada remaja untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi kesehatan online. Fokus pada kemampuan memahami dan memfilter informasi kesehatan yang akurat dan dapat dipercaya.

2. Panduan Penggunaan Aplikasi Kesehatan:

Memberikan panduan tentang cara menggunakan aplikasi kesehatan dan nutrisi yang dapat membantu remaja memantau asupan makanan, pertumbuhan, dan kesehatan mereka. Memastikan remaja memahami cara memanfaatkan fitur-fitur aplikasi tersebut.

3. Kampanye Literasi Digital:

Mengorganisir kampanye literasi digital yang fokus pada kesehatan dan nutrisi, memfasilitasi remaja dalam mengenali dan mengakses informasi secara online. Mendorong remaja untuk berpartisipasi aktif dalam kampanye tersebut melalui media sosial atau platform online lainnya.

4. Webinar dan Sesi Virtual:

Menyelenggarakan webinar atau sesi virtual tentang literasi digital dan pencegahan stunting. Memberikan informasi tentang cara menggunakan sumber daya online dengan bijak untuk meningkatkan pengetahuan gizi dan kesehatan.

5. Forum Diskusi Online:

Membuat forum diskusi online yang memungkinkan remaja berbagi informasi, pengalaman, dan tips terkait pencegahan stunting menggunakan literasi digital. Mendorong pertukaran ide dan dukungan antarremaja.

6. Penggunaan Media Sosial untuk Edukasi:

Menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi edukatif tentang pencegahan stunting dan praktik gizi sehat. Menyediakan konten yang menarik dan relevan bagi remaja.

7. Pendampingan Individu:

Memberikan dukungan individu kepada remaja yang mungkin memerlukan bantuan lebih lanjut dalam memahami informasi kesehatan digital. Membimbing mereka dalam menggunakan teknologi untuk memantau pertumbuhan dan mempraktikkan pola makan sehat.

8. Penciptaan Konten Digital:

Mendorong remaja untuk menciptakan konten digital, seperti blog, vlog, atau infografis, yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya gizi dan pencegahan stunting. Memberikan platform untuk ekspresi kreatif mereka.

9. Monitoring Kemajuan Melalui Aplikasi:

Mengajarkan cara menggunakan aplikasi pemantauan pertumbuhan anak dan menginterpretasi hasilnya. Melibatkan remaja dalam memantau kemajuan mereka sendiri atau keluarga mereka.

10. Pengenalan Sumber Daya Online yang Berkualitas:

Membimbing remaja dalam mengenali dan menggunakan sumber daya online yang dapat dipercaya

dan berkualitas tinggi terkait kesehatan dan pencegahan stunting.

Melibatkan *peer educator* dalam upaya literasi digital dapat menciptakan iklim yang mendukung dan memotivasi remaja untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan digital yang relevan dengan pencegahan stunting. Ini juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian remaja dalam merawat kesehatan mereka sendiri.

Penggunaan literasi digital sebagai alat dalam upaya pencegahan stunting pada remaja dapat dianggap lebih efektif daripada modul pencegahan stunting dengan beberapa alasan berikut:

1. Aksesibilitas dan Kecepatan:

Literasi digital memungkinkan informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah melalui berbagai platform online. Remaja umumnya memiliki akses yang lebih baik ke teknologi digital, seperti ponsel pintar dan internet, sehingga informasi dapat dengan cepat disampaikan kepada mereka tanpa keterbatasan fisik modul cetak.

2. Interaktivitas dan Keterlibatan:

Literasi digital memungkinkan penggunaan konten interaktif seperti video, gambar bergerak, infografis, dan kuis online. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan remaja dan membantu mereka memahami informasi dengan lebih baik. Sifat interaktif ini dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif.

3. Pembaruan Informasi Secara Real-Time:

Literasi digital memungkinkan pembaruan informasi secara real-time. Dalam konteks pencegahan stunting, ada kemungkinan adanya perkembangan baru dalam

penelitian atau saran kesehatan yang dapat segera diperbarui dan disampaikan melalui literasi digital.

4. Fleksibilitas dan Adaptabilitas:

Literasi digital memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penyampaian informasi. Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi remaja, sehingga pesan pencegahan stunting dapat lebih efektif disesuaikan dengan konteks kehidupan mereka.

5. Jangkauan yang Lebih Luas:

Literasi digital memungkinkan pesan pencegahan stunting dapat dengan mudah dibagikan melalui media sosial, pesan teks, atau aplikasi berbasis internet lainnya. Hal ini dapat memperluas jangkauan pesan dan mencapai lebih banyak remaja dengan cara yang lebih cepat dan efektif.

6. Kemampuan Monitoring dan Evaluasi:

Melalui literasi digital, Anda dapat lebih mudah melacak interaksi remaja dengan materi pencegahan stunting. Dengan adanya data ini, program pencegahan dapat dievaluasi untuk mengidentifikasi apa yang efektif dan apa yang perlu ditingkatkan.

C. Hasil Literasi Digital Pencegahan Stunting

Hasil literasi digital pencegahan stunting merupakan tema yang sangat relevan dan penting, mengingat perkembangan teknologi digital yang semakin pesat dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital saat ini, akses terhadap informasi tidak lagi terbatas pada media tradisional, melainkan dapat diperoleh dengan mudah melalui internet. Salah satu manfaat utama dari peningkatan literasi digital adalah kemampuannya dalam menyebarkan informasi yang dapat mengubah perilaku masyarakat, termasuk dalam hal

pencegahan stunting. Stunting, yang merupakan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu lama, masih menjadi masalah besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk itu, literasi digital memiliki potensi besar dalam mengedukasi masyarakat, khususnya keluarga dan remaja, mengenai pentingnya pola makan yang sehat, gizi seimbang, serta pemahaman tentang kesehatan ibu dan anak yang berkelanjutan.

Hasil literasi digital dalam pencegahan stunting dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyebab dan dampak stunting, perubahan perilaku terkait pola makan sehat, serta keterlibatan masyarakat dalam kampanye pencegahan stunting yang lebih luas. Salah satu aspek pertama yang dapat dilihat adalah peningkatan pengetahuan. Dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti situs web, media sosial, dan aplikasi kesehatan, informasi mengenai stunting dapat disebarkan secara luas dan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Aplikasi dan situs web yang memberikan informasi mengenai gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pemantauan pertumbuhan anak, telah terbukti dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi yang baik selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) — periode kritis dalam perkembangan fisik dan otak anak.

Beberapa platform digital, seperti situs kesehatan, blog, dan media sosial, juga menyediakan informasi berbentuk infografis atau video yang menarik, mempermudah pemahaman tentang topik yang kompleks seperti stunting. Selain itu, adanya aplikasi yang memberikan tips dan rekomendasi seputar gizi yang tepat bagi ibu hamil dan anak-anak, seperti pengingat untuk memberikan ASI

eksklusif dan mengonsumsi makanan bergizi, turut berperan dalam mendidik masyarakat agar lebih peduli terhadap pola makan sehat. Informasi yang lebih mudah diakses ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai pencegahan stunting, dan bukan hanya informasi yang didapatkan dari sumber-sumber yang tidak jelas.

Selain itu, literasi digital juga mampu mengubah perilaku masyarakat, khususnya terkait dengan pemilihan pola makan dan kebiasaan gizi yang lebih sehat. Dalam konteks pencegahan stunting, informasi yang disebarakan melalui media digital dapat mempengaruhi sikap dan keputusan keluarga dalam hal pemberian makanan yang bergizi. Dengan meningkatnya pemahaman tentang pentingnya asupan gizi yang seimbang, banyak orang tua yang mulai mengubah pola makan keluarga mereka, memperkenalkan lebih banyak sayuran, buah-buahan, dan protein dalam makanan sehari-hari anak-anak mereka. Akses mudah ke informasi ini juga memungkinkan ibu hamil untuk mendapatkan edukasi yang lebih tepat tentang pentingnya gizi selama kehamilan dan menyusui. Melalui literasi digital, ibu hamil dan orang tua menjadi lebih sadar tentang konsekuensi dari kekurangan gizi pada masa kehamilan, yang berpotensi menyebabkan stunting pada anak.

Terkait dengan perubahan perilaku ini, keterlibatan aktif dari sektor kesehatan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam menggunakan media digital untuk menyebarkan pesan-pesan pencegahan stunting juga memberikan dampak yang signifikan. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan mulai menggandeng influencer atau tokoh publik untuk mempromosikan pesan-pesan penting tentang

pencegahan stunting melalui media sosial. Misalnya, selebritas atau tokoh masyarakat yang memanfaatkan akun media sosial mereka untuk berbagi informasi tentang pola makan sehat dan pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran tentang stunting, terutama di kalangan orang tua muda.

Dalam hal ini, penggunaan media sosial dan aplikasi komunikasi berbasis digital juga memungkinkan penyebaran kampanye pencegahan stunting secara lebih luas. Kampanye-kampanye yang diluncurkan di platform seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, misalnya, dapat menjangkau kalangan orang tua muda dan remaja, kelompok yang cenderung lebih aktif menggunakan teknologi digital. Dengan melibatkan mereka secara langsung dalam diskusi atau penyebaran informasi, ada peluang besar untuk mempercepat perubahan dalam pola pikir dan perilaku terhadap isu gizi dan kesehatan anak. Aktivitas seperti live streaming atau webinar yang mengangkat tema pencegahan stunting dan pola makan sehat juga memberikan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan ahli gizi atau tenaga kesehatan, memperkuat pemahaman dan mendorong penerapan kebiasaan yang lebih baik.

Untuk memastikan bahwa literasi digital benar-benar berdampak pada pencegahan stunting, penting juga untuk memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan adalah akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam pelaksanaan literasi digital adalah banyaknya informasi yang tidak valid atau bahkan salah yang beredar di internet. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga kesehatan, dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan sumber daya yang

kredibel dan memverifikasi informasi yang ada, guna menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan. Keberadaan platform yang menyediakan informasi yang terverifikasi, serta edukasi mengenai cara memilah informasi yang benar dan salah, akan semakin memperkuat literasi digital masyarakat.

Keberhasilan literasi digital dalam pencegahan stunting juga sangat bergantung pada pemerataan akses terhadap teknologi. Masyarakat di daerah terpencil atau dengan kondisi ekonomi terbatas mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses internet atau perangkat digital. Oleh karena itu, penting untuk menjangkau mereka dengan menggunakan berbagai pendekatan, misalnya melalui program pelatihan literasi digital yang dilaksanakan di desa-desa atau kawasan terpencil. Program-program tersebut dapat disertai dengan penyuluhan langsung melalui kegiatan komunitas atau kelompok belajar untuk mengajarkan cara mengakses informasi kesehatan yang bermanfaat melalui perangkat digital.

Secara keseluruhan, hasil literasi digital dalam pencegahan stunting sangat signifikan. Melalui peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, dan keterlibatan masyarakat dalam kampanye pencegahan stunting, literasi digital dapat berperan sebagai alat penting dalam menanggulangi masalah gizi buruk yang masih marak di banyak negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat untuk terus mendukung dan memperluas literasi digital di kalangan masyarakat, guna menciptakan generasi yang sehat dan bebas dari stunting.

BAB 4

PENGUNAAN LITERASI DIGITAL DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN REMAJA TERHADAP PENCEGAHAN STUNTING

A. Pengetahuan tentang Stunting melalui Metoda *Peer Educator* Pada Remaja

Stunting menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan masa bayi/balita, termasuk penyakit yang diderita selama masa balita. Seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga dipengaruhi berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan (Kemenkes RI, 2016). Untuk melakukan penanganan masalah *stunting* dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak terkait yang ada di masyarakat utamanya keterlibatan remaja dalam upaya pencegahan *stunting*.

Untuk melakukan pencegahan masalah *stunting* melalui upaya pemberdayaan remaja terhadap pencegahan *stunting* dengan penggunaan literasi digital. Mengingat pengaruh lingkungan seperti kelompok atau teman dapat memicu terjadinya perubahan perilaku seperti kebiasaan makan yang tidak baik dan tersedianya berbagai macam makanan dengan kandungan gizi yang tidak seimbang dapat memicu terjadinya *stunting*. *Peer educator* dapat diajak kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat atau remaja dalam memberikan berbagai edukasi yang dibutuhkan, dan

informasi berasal dari pedoman kesehatan, materi pelatihan medis, atau petunjuk dari tenaga kesehatan profesional. Kolaborasi dengan petugas kesehatan setempat dan dukungan dari lembaga kesehatan dapat membantu memastikan bahwa *peer educator* memiliki informasi dan keterampilan yang diperlukan untuk efektif dalam mendampingi remaja dan melibatkan mereka dalam pencegahan stunting.

Hasil penelitian Rahmawati., et al (2018) menunjukkan bahwa prevalensi remaja *stunting* yang didapatkan dari penelitian ini adalah 16,4% lebih rendah jika dibandingkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 untuk usia remaja 16-18 tahun skala nasional. Faktor resiko yang berpengaruh terhadap kejadian *stunting* adalah pendidikan ayah dengan nilai *oods ratio* (OR) 1,912; CI 95% meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan *stunting* untuk generasi selanjutnya. Mengingat hal tersebut penting dilakukan upaya pencegahan *stunting* melui pemberdayaan remaja sebagai generasi penerus yang sangat dibutuhkan perannya dalam menurunkan kejadian *stunting*.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pada kelompok perlakuan diperoleh hasil tingkat pengetahuan sebelum diberikan perlakuan (pre test) sebagian besar siswa memiliki tingkat pengetahuan kurang. Kemudian sesudah diberikan perlakuan (post test) sebagian besar siswa memiliki tingkat pengetahuan baik. Hasil perbandingan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol terhadap tingkat pengetahuan sesudah diberikan perlakuan (post test) yang dilakukan menggunakan uji Mann-Whitney diperoleh nilai signifikansi, sehingga dinyatakan terdapat perbedaan signifikan antara kelompok

perlakuan dan kelompok kontrol terhadap tingkat pengetahuan sesudah diberikan perlakuan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tingkat pengetahuan siswa pada kelompok perlakuan. Pengetahuan tentang stunting yang diberikan kepada subyek penelitian berhasil meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam upaya pencegahan stunting pada remaja. Pemberian pengetahuan melalui pada sekelompok masyarakat dengan metode *peer educator* efektif dalam upaya peningkatan pengetahuan. Hal ini didukung oleh beberapa hal positif yang didapatkan dari *peer educator* yaitu membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat dan memungkinkan orang yang menerima edukasi untuk merasa lebih nyaman dan dapat membantu dalam membentuk persepsi dan pemahaman kelompok sebaya terhadap suatu isu atau topik.

Proses belajar *peer educator* juga melibatkan peserta aktif sehingga pengetahuan yang diperoleh akan bertahan lebih lama. Metode ini dianggap cocok karena merupakan salah satu metode yang efektif untuk menyebarkan informasi. Pendidikan sebaya merupakan suatu proses KIE dengan pendekatan komunikasi yang dilakukan kalangan sebaya yaitu kelompok yang sama yang bertujuan untuk memberi perubahan pada yang lain dengan mencoba untuk mengubah pengetahuan, sikap, keyakinan atau perilaku. Pendidikan sebaya adalah bentuk dari rasa senasib sepenanggungan yang dapat dilakukan dalam bentuk dari rasa senasib sepenanggungan yang dapat dilakukan dalam bentuk komunikasi dua arah.

Metoda yang dipakai dalam pendidikan kesehatan hendaknya dapat mengembangkan komunikasi dua arah antara yang memberikan pendidikan kesehatan terhadap

sasaran, sehingga diharapkan pesan yang disampaikan akan lebih jelas dan mudah dipahami. Pendidikan kesehatan dengan pendekatan kelompok merupakan pilihan yang cukup efektif. Pendekatan kelompok memberikan dukungan bagi anggotanya dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan untuk mengubah perilakunya serta memelihara perilaku yang sehat.

Peer educator dapat berfungsi dalam mendampingi dan memberikan edukasi tentang stunting serta mempengaruhi sikap remaja: 1) Sebagai rekan sebaya, peer educator dapat menjadi contoh yang relevan bagi remaja. Dengan berbagi pengalaman pribadi atau menunjukkan bagaimana mereka sendiri dapat mencegah stunting, mereka dapat menjadi sumber inspirasi yang lebih kuat bagi remaja, 2) Peer educator dapat menciptakan lingkungan yang mendukung di mana remaja merasa nyaman berbicara tentang topik sensitif seperti stunting. Komunikasi yang terbuka dapat membantu mengatasi stigmatisasi dan mendorong remaja untuk mencari informasi lebih lanjut, 3) Peer educator dapat menggunakan metode edukasi yang menarik dan sesuai dengan gaya belajar remaja. misalnya, melibatkan kegiatan interaktif, penggunaan media sosial, atau menyampaikan informasi melalui cerita-cerita yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, 4) Peer educator dapat membantu remaja memahami dampak jangka panjang dari stunting terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Menyoroti konsekuensi jangka panjang dapat meningkatkan kesadaran remaja akan pentingnya pencegahan stunting sejak dini, 5) Peer educator dapat berfokus pada promosi gaya hidup sehat yang dapat mencegah stunting, seperti pola makan seimbang, nutrisi yang cukup, dan perawatan kesehatan yang baik. Mereka

dapat memberikan informasi praktis dan tips yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari remaja, 6) Memberdayakan remaja dengan pengetahuan tentang pencegahan stunting dapat membuat mereka merasa memiliki kontrol atas kesehatan mereka sendiri dan masa depan generasi mendatang. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan rasa tanggung jawab remaja terhadap kesejahteraan anak-anak di masa depan.

Metode *peer educator* diharapkan akan berdampak pada peningkatan pengetahuan mengenai stunting yang baik sehingga kemampuan yang dimiliki kader tersebut akan ditularkan pada sesama kader, keluarga dan masyarakat dalam penerapan kesehatan dan gizi status gizi dan stunting tidak terjadi.

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian menunjukkan kejadian stunting merupakan suatu proses kumulatif sejak kehamilan. Oleh karena itu, faktor gizi ibu selama kehamilan merupakan penyebab tidak langsung yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Ibu hamil dengan gizi kurang akan menyebabkan janin mengalami *intrauterin growth retardation* (IUGR) sehingga bayi tersebut akan lahir dengan kurang gizi dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit, kurangnya kemampuan kognitif dan memiliki postur tubuh yang tidak maksimal saat dewasa.

Pengetahuan gizi membuat orang untuk belajar dalam menggunakan dan memilih makanan yang lebih baik untuk

kesejahteraannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan gizi seseorang diharapkan semakin baik pula keadaan gizinya (Fajar , 2017). Hasil yang diharapkan dalam pendidikan kesehatan masyarakat melalui *peer educator* adalah terjadinya perubahan sikap dan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat untuk dapat menanamkan prinsip-prinsip hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari demi mencapai derajat kesehatan yang optimal.

B. Sikap Remaja terhadap Pencegahan Stunting

Untuk mengetahui tingkat sikap pada kelompok perlakuan diperoleh hasil tingkat sikap sebelum diberikan perlakuan (pre test) terdapat sebagian besar siswa memiliki tingkat sikap mendukung. Kemudian sesudah diberikan perlakuan (post test) semua siswa memiliki tingkat sikap mendukung. Hasil perbandingan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol terhadap tingkat sikap sesudah diberikan perlakuan (post test) yang dilakukan menggunakan uji Mann-Whitney diperoleh nilai signifikansi, sehingga dinyatakan terdapat perbedaan signifikan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol terhadap tingkat sikap sesudah diberikan perlakuan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tingkat sikap siswa pada kelompok perlakuan.

Dalam pendidikan sebaya remaja dapat lebih terbuka dan percaya dalam menyampaikan pikirannya karena remaja sudah merasa akrab terlebih dahulu dengan *peer educator*, sehingga tidak ada ketakutan dari setiap individu dalam bertanya ataupun berpendapat. Menurut Clayton dan Mercer dalam Setyaningsih (2016) menjelaskan bahwa keakraban dengan suatu objek dapat mendorong sikap positif terhadap objek tersebut.

Orang yang paling sering ditemui dan berinteraksi adalah yang paling mungkin menjadi teman sehingga menimbulkan keakraban. Sehingga pada pemilihan pendidik sebaya dalam penelitian ini, diupayakan mereka yang mempunyai pengaruh dan menjadi panutan pada teman sebayanya.

Pemenuhan kebutuhan emosional individu mulai beralih dari orang tua ke teman sebaya saat masa remaja. Dukungan antar teman sebaya dalam pendidikan sebaya ini dapat menjadi wadah dalam meningkatkan partisipasi remaja untuk mengikuti program pendidikan kesehatan. Remaja akan lebih terbuka dan percaya dalam menyampaikan hal-hal yang sensitif bahkan di luar topik pembahasan dan masalah yang ada dapat diselesaikan dengan mudah melalui pendidikan sebaya.

Pendidikan sebaya bahkan digunakan sebagai metode dalam pendidikan formal di perguruan tinggi seperti dalam penelitian Grover tentang *Pathology Reform by PeerAssisted Learning* yakni mereformasi ajaran patologi di perguruan tinggi kedokteran dengan pembelajaran dimana siswa bertindak sebagai guru sebaya dan membantu siswa lain untuk belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegunaan *peer teaching* dengan mendapatkan umpan balik dari siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa lebih mudah dalam memahami dan berinteraksi serta keterlibatan siswa sebagai manfaat terpenting pembelajaran *peer assisted*. Hal inilah yang mendukung pemberian informasi mengenai pencegahan *stunting* lebih besar pengaruhnya apabila diberikan oleh teman sebaya melalui pendidikan sebaya.

C. Pemeriksaan Hemoglobin pada Remaja

Hasil penelitian menunjukkan tingkat keterampilan sebelum diberikan perlakuan (pre test) terdapat sebagian besar siswa memiliki tingkat keterampilan kurang. Kemudian sesudah diberikan perlakuan (post test) terdapat sebagian besar siswa memiliki tingkat keterampilan baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tingkat keterampilan siswa pada kelompok perlakuan.

Peer educator dapat berfungsi dalam mendampingi dan memberikan edukasi, termasuk melatih ketrampilan pemeriksaan HB pada remaja: 1) *Peer educator* dapat memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada remaja mengenai hubungan antara anemia dan stunting. Mereka dapat menjelaskan pentingnya ketersediaan zat besi dalam tubuh dan bagaimana defisiensi zat besi dapat berkontribusi pada pertumbuhan yang tidak optimal pada anak-anak, 2) *Peer educator* dapat memberikan penjelasan rinci tentang cara melakukan pemeriksaan HB atau hematokrit, termasuk langkah-langkah yang diperlukan dan peralatan yang digunakan. Hal ini membantu remaja memahami pentingnya pemeriksaan tersebut dalam upaya pencegahan stunting, 3) *Peer educator* dapat melakukan demonstrasi praktik secara langsung tentang cara mengambil sampel darah untuk pemeriksaan HB. Mereka dapat menunjukkan teknik pengambilan sampel yang benar dan menjelaskan langkah-langkah sterilisasi untuk menghindari risiko infeksi, 4) Setelah pemeriksaan dilakukan, *peer educator* dapat membantu remaja memahami hasil pemeriksaan HB. Mereka dapat menjelaskan nilai normal, tanda-tanda anemia, dan langkah-langkah selanjutnya jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya masalah, 5) Jika diperlukan, *peer educator* dapat memberikan pelatihan praktis tentang penggunaan alat

pemeriksaan HB. Mereka dapat memastikan bahwa remaja dapat menggunakan alat tersebut dengan benar untuk mendapatkan hasil yang akurat, dan 6) Peer educator dapat melibatkan remaja dalam kegiatan pemantauan berkala, termasuk pemeriksaan HB secara rutin. Ini dapat membantu dalam mendeteksi dini kondisi anemia dan mengambil tindakan pencegahan lebih lanjut.

Hal ini sejalan pula dengan hasil penelitian Rahmawati, (2015) mengenai pelatihan keterampilan konseling berbasis modul dapat meningkatkan keterampilan dasar konseling konselor sebaya PIK R MAN Yogyakarta 1 yang dilihat dari rata-rata persentase dari 34,42% menjadi 73,85%. Pemberian pelatihan merupakan suatu proses belajar untuk memberikan keterampilan baru guna pengembangan sumber daya manusia. Indikator efektivitas pelatihan dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya tambahan pengetahuan atau kemampuan peserta atau wawasan, kemampuan peserta mengingat isi pelatihan atau kemampuan peserta mempraktikkan materi pelatihan atau trampil.

BAB 5

PENUTUP

Dalam upaya mencegah stunting pada remaja, peran *peer educator* berbasis literasi digital menjadi strategi yang efektif dan relevan di era modern. Pemberdayaan remaja melalui pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan mereka tentang pentingnya gizi, kesehatan reproduksi, dan pola hidup sehat, tetapi juga memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan di lingkungan sekitar. Remaja yang diberdayakan memiliki potensi besar untuk mempengaruhi teman sebaya melalui pendekatan yang lebih personal, interaktif, dan sesuai dengan dinamika sosial mereka.

Teknologi digital memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan program ini. Platform media sosial, aplikasi edukasi, serta konten digital yang menarik menjadi sarana utama untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan dengan cara yang kreatif dan mudah diterima. Dengan literasi digital yang baik, para remaja mampu mengakses informasi yang valid, menyaring hoaks, serta menyampaikan pesan kesehatan dengan cara yang inovatif kepada kelompok sebaya.

Lebih jauh, pendekatan *peer educator* berbasis literasi digital juga memberikan peluang bagi remaja untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi. Program ini mendorong terciptanya komunitas remaja yang sadar kesehatan, mendukung satu sama lain, dan berkomitmen untuk menciptakan generasi bebas stunting. Dengan demikian, intervensi ini tidak hanya berdampak pada

individu, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat secara luas.

Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan program ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Orang tua, pendidik, tenaga kesehatan, dan pemangku kebijakan memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemberdayaan remaja. Kolaborasi lintas sektor yang solid akan memperkuat efektivitas intervensi ini, sekaligus memastikan keberlanjutan program di masa depan.

Melalui pemberdayaan remaja sebagai *peer educator* berbasis literasi digital, harapan untuk mengurangi angka stunting pada remaja dapat terwujud. Dengan kombinasi pengetahuan, teknologi, dan aksi nyata, generasi muda tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam menciptakan perubahan positif. Upaya ini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berkualitas, demi masa depan bangsa yang lebih baik.

Dengan diberikannya pelatihan ketrampilan dalam pemeriksaan Hb, maka *Peer educator* dapat berfungsi dalam mendampingi dan memberikan edukasi, termasuk melatih ketrampilan pemeriksaan HB pada remaja: 1) *Peer educator* dapat memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada remaja mengenai hubungan antara anemia dan stunting. Mereka dapat menjelaskan pentingnya ketersediaan zat besi dalam tubuh dan bagaimana defisiensi zat besi dapat berkontribusi pada pertumbuhan yang tidak optimal pada anak-anak, 2) *Peer educator* dapat memberikan penjelasan rinci tentang cara melakukan pemeriksaan HB atau hematokrit, termasuk langkah-langkah yang diperlukan dan peralatan yang digunakan. Hal ini membantu remaja memahami pentingnya pemeriksaan tersebut dalam upaya pencegahan stunting,

DAFTAR PUSTAKA

- Ainy, F. N., Susanto, T., & Susumaningrum, L. A. (2021). The relationship between environmental sanitation of family and stunting among under-five children: A cross-sectional study in the public health center of Jember, Indonesia. *Nursing Practice Today*, 8(3), 173–178. <https://doi.org/10.18502/npt.v8i3.5932>
- Alexander, S., Ostfeld, R. J., Allen, K., & Williams, K. A. (2017). A plant-based diet and hypertension. *Journal of Geriatric Cardiology*, 14(5), 327–330. <https://doi.org/10.11909/j.issn.1671-5411.2017.05.014>
- Aljuraiban, G., Chan, Q., Gibson, R., Stamler, J., Daviglus, M. L., Dyer, A. R., Miura, K., Wu, Y., Ueshima, H., Zhao, L., Van Horn, L., Elliott, P., & Oude Griep, L. M. (2020). Association between plant-based diets and blood pressure in the INTERMAP study. *BMJ Nutrition, Prevention & Health*, 3(2), 133–142. <https://doi.org/10.1136/bmjnp-2020-000077>
- Allender, J. A., & Spardley, B. W. (2011). *Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public's Health*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Anderson, E., & McFarlane, J. (2004). *Community As Partner: Theory and Practice in Nursing* (4th Edition). Lippincott Williams & Wilkins.
- Aristi, D. L. A., Rasni, H., Susumaningrum, L. A., Susanto, T., & Siswoyo, S. (2020). Hubungan Konsumsi Makanan Tinggi Natrium dengan Kejadian Hipertensi pada Buruh Tani di Wilayah Kerja Puskesmas Panti Kabupaten Jember. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(1), 53–60.

<https://doi.org/10.22435/hsr.v23i1.2741>

- Asmawati, Ambar Sari, D., Ihromi, S., Nurhayati, Pacitra, S., Danela Luthfiah, T., & Rizal, H. (2021). Cegah Stunting Dan Gizi Buruk Pada Balita Dengan Edukasi Gizi Bagi Tumbuh Kembang Anak Di Desa Banyumulek Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Agro Dedikasi Masyarakat (JADM)*, 2(2), 7–12. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jadm>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2022). *Laporan Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia 2022*. Jakarta: APJII.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2022). *Laporan Nasional Prevalensi Stunting 2022*. Jakarta: BKKBN.
- Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Bappenas. (2020). Laporan Pembangunan Pemuda Indonesia 2020. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Budiwibowo, S. (2016). Membangun Pendidikan Karakter Generasi Muda Melalui Budaya Kearifan Lokal Di Era Global. *Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar Dan Pembelajaran*, 3(01), 39–49. <https://doi.org/10.25273/pe.v3i01.57>
- Dinkes Jawa Timur. (2020). Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2019. *Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*, 1–73. www.dinkesjatengprov.go.id
- Fajar, I., 2017. Model Penanganan Stunting Berdasarkan Analisis Faktor Pada Anak Balita di Kabupaten Malang. Poltekkes Kemenkes Malang

- Gupta, A. K., Mongia, M., & Garg, A. K. G. (2018). A descriptive study of behavioral problems in schoolgoing children. *Industrial Psychiatry Journal*, 195–201. <https://doi.org/10.4103/ipj.ipj>
- Halder, S., & Kejriwal, S. (2016). Nutritional awareness of mothers in relation to nutritional status of the preschool children. *Early Child Development and Care*, 186(9), 366–377.
- Handayani, D., Kusuma, E., Puspitasari, H., & Nastiti, A. D. (2022). The Factors Affecting Stunting on Toddlers in Coastal Areas. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(3), 755–764. <https://doi.org/10.30604/jika.v7i3.967>
- Harahap, R. A., Rochadi, R. K., & Sarumpae, S. (2018). Pengaruh Aktivitas Fisik Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Laki-Laki Dewasa Awal (18-40 Tahun) Di Wilayah Puskesmas Bromo Medan Tahun 2017. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 1(2), 68–73. <https://doi.org/10.24912/jmstkik.v1i2.951>
- Hever, J., & Cronise, R. J. (2017). Plant-based nutrition for healthcare professionals: Implementing diet as a primary modality in the prevention and treatment of chronic disease. *Journal of Geriatric Cardiology*, 14(5), 355–368. <https://doi.org/10.11909/j.issn.1671-5411.2017.05.012>
- Isnaini, A. F., Susanto, T., Susumaningrung, L. A., Rasni, H., & Siswayo, S. (2020). Hubungan fungsi keluarga dengan status gizi balita pada keluarga tiri di kecamatan panti kabupaten jember. *Jurnal Ilmu Keperawatan Komunitas*, 3(1), 1–10.
- Joshi, S., Hashmi, S., Shah, S., & Kalantar-Zadeh, K. (2020). Plant-based diets for prevention and management of chronic

kidney disease. *Current Opinion in Nephrology and Hypertension*, 29(1), 16–21.
<https://doi.org/10.1097/MNH.0000000000000574>

- Kavosi, E., Rostami, Z., Kavosi, Z., Nasihatkon, A., Moghadami, M., & Heidari, M. (2014). Prevalence and determinants of under-nutrition among children under six: a cross-sectional survey in Fars province. *Iran Int J Health Policy Manag*, 3(2), 71–76.
- Kemendikbudristek. (2022). Program Sekolah Digital Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
- Kemenkes RI. (2016). *Pedoman Umum Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga* (Vol. 21, Issue 1). Kementerian Kesehatan RI. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Kemenkes RI. 2016. Situasi balita pendek. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kusuma, D., & Handayani, T. (2021). *Digital Literacy in Health Education: A Case Study of Adolescent Knowledge Improvement*. *Journal of Public Health Education*, 45(2), 150–160.
- Larson, R. (2000). Towards a psychology of positive youth development. *American Psychologist*, 55(1), 170–183.
- Nasir, F., et al. (2021). *Digital Literacy and Youth Empowerment in Health Education*. *Journal of Health Promotion*, 34(3), 256–269.

- Nasir, F., et al. (2021). *Peer Education and Youth Empowerment in Health Promotion*. Asian Journal of Health Promotion, 8(3), 34–42.
- Notoatmodjo, S. 2018. Ilmu Perilaku Kesehatan. Rineka Cipta: Jakarta
- Rahmawati, 2018. Gambaran Masalah Gizi pada 1000 HPK di Kota dan Kabupaten Malang, Indonesian Journal of Human Nutrition, juni 2016, Vol.3 No.1 Suplemen: 20-31
- Santrock, J. W. (2019). Adolescence (16th ed.). McGraw-Hill Education.
- Setyaningsih, 2016, Pengaruh Karakteristik Ibu terhadap kejadian stunting balita, Jurnal Untuk Masyarakat Sehat, DOI:[10.52643/jukmas.v8i2.4420](https://doi.org/10.52643/jukmas.v8i2.4420)
- Setyawati, D., et al. (2020). *Impact of Peer Educators on Adolescent Health Awareness*. Indonesian Journal of Public Health, 13(4), 267–274.
- UNICEF. (2022). *Youth as Agents of Change in Health Promotion*. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2022). *Youth as Agents of Change in Stunting Prevention*. New York: UNICEF.
- WHO. (2021). *Stunting: Causes and Consequences*. Geneva: World Health Organization.
- WHO. (2021). *Stunting: Policy and Progress*. Geneva: World Health Organization.
- Yulianti, R., & Nurhalimah, S. (2022). *The Role of Digital Media in Health Literacy Among Adolescents*. Journal of Adolescent Studies, 12(1), 45–58.

PROFIL PENULIS



Tavip Dwi Wahyuni, S.Kep., Ns., M.Kes., lahir di Malang, 20 Februari 1965. Pendidikan S-1 di Fakultas Keperawatan Universitas Brawijaya (UB) Malang (Lulus 2002). Pascasarjana di Fakultas Kedokteran Keluarga Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) (Lulus 2010). Saat ini sedang menempuh Pendidikan S3 pada Program Studi Teknologi Pembelajaran (TEP) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang (UM).

Aktivitas penulis saat ini mengajar pada jenjang Sarjana Terapan pada Program Studi Promosi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Jalin kerja sama dengan penulis via surel tavipdw202@gmail.com

Motto: "Membaca adalah pintu gerbang keterampilan yang membuat semua pembelajaran lainnya menjadi mungkin. Ayo semangat membaca"

PROFIL PENULIS



Dr. Atti Yudiernawati, SKp., M.Pd., lahir di Madiun, 09 Mei 1966, Pendidikan S1 PSIK Universitas Padjajaran lulus tahun 1999, S2 dan S3 di Program Stufi Teknologi Pembelajaran, Universitas Negeri Malang lulus tahun 2014. Sejak tahun 1990 bekerja di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang mengampu mata kuliah Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan, Pengembangan

kepribadian dan Penerapan strategi perubahan perilaku. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai leneliti , publikasi, pengabdian masyarakat seminar, dan Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ayudiernawati@gmail.com

Motto: "Living your life well", sebaik baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat



Pudji Suryani, SKp., MKM., lahir di Malang, 20 Januari 1970, Saat ini penulis tinggal di Malang, Jawa Timur. Pendidikan Tinggi yang ditempuh mulai S1 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia (UI) lulus tahun 2004. Pascasarjana di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesai (UI) (lulus 2012). Aktivitas penulis saat ini mengajar

pada jenjang sarjana terapan pada Program Studi Promosi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang.

SINOPSIS BUKU

Pemberdayaan remaja adalah konsep dan pendekatan yang berfokus pada memberikan individu dan kelompok remaja, sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan kekuatan yang diperlukan untuk mengambil kontrol atas hidup mereka sendiri dan mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi.

Tujuan utama dari pemberdayaan remaja adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Bentuk pemberdayaan remaja berupa Pendidikan dan pelatihan *Peer Educator* tentang pencegahan stunting menggunakan bantuan literasi digital.

Melalui pemberdayaan remaja yang teroganisir, diharapkan pencegahan stunting dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan meluas terutama pada remaja sebagai generasi penerus yang produktif, sehat serta terhindar dari stunting.

Pemberdayaan remaja adalah konsep dan pendekatan yang berfokus pada memberikan individu dan kelompok remaja, sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan kekuatan yang diperlukan untuk mengambil kontrol atas hidup mereka sendiri dan mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi.

Tujuan utama dari pemberdayaan remaja adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Bentuk pemberdayaan remaja berupa Pendidikan dan pelatihan Peer Educator tentang pencegahan stunting menggunakan bantuan literasi digital.

Melalui pemberdayaan remaja yang teroganisir, diharapkan pencegahan stunting dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan meluas terutama pada remaja sebagai generasi penerus yang produktif, sehat serta terhindar dari stunting.

Penerbit:
PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480
Telp: (021) 29866919

